

Buku Referensi

KEBIDANAN TRANSKULTURAL

Dalam Masyarakat Multikultural Indonesia

Dian Rahmawati • Nurdiana Lante • Sahnawi Marsaoly
Silvia Nova • Siti Komariyah



BUKU REFERENSI KEBIDANAN TRANSKULTURAL DALAM MASYARAKAT MULTIKULTURAL INDONESIA

Penulis:

Dian Rahmawati, SST., MPH.
Dr. Nurdiana Lante, S.ST., M.Kes.
Sahnawi Marsaoly, S.Kep., M.Kes.
Dr. Bd. Silvia Nova, SST., M.Kes.
Siti Komariyah, S.SiT., M.Kes.



**Optimal
Untuk
Negeri**

Buku Referensi Kebidanan Transkultural dalam Masyarakat Multikultural Indonesia

Penulis:

Dian Rahmawati, SST., MPH.
Dr. Nurdiana Lante, S.ST., M.Kes.
Sahnawi Marsaoly, S.Kep., M.Kes.
Dr. Bd. Silvia Nova, SST., M.Kes.
Siti Komariyah, S.SiT., M.Kes.

Desain Sampul: Ivan Zumarano

Penata Letak: Muhamad Rizki Alamsyah

ISBN: 978-634-7556-99-8

Cetakan Pertama : Mei, 2026

Hak Cipta 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2026

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku yang berjudul "Buku Referensi Kebidanan Transkultural dalam Masyarakat Multikultural Indonesia" ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai bentuk kontribusi penulis dalam memperkaya khasanah ilmu kebidanan, khususnya dalam memahami praktik kebidanan dari perspektif budaya yang beragam di Indonesia.

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki keberagaman budaya, adat istiadat, kepercayaan, serta nilai-nilai sosial yang sangat kompleks. Keberagaman tersebut secara langsung memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap kesehatan, kehamilan, persalinan, hingga perawatan ibu dan bayi. Oleh karena itu, tenaga kebidanan dituntut untuk memiliki sensitivitas budaya serta kemampuan dalam memberikan pelayanan yang tidak hanya berbasis ilmu pengetahuan, tetapi juga menghormati nilai-nilai dan keyakinan yang dianut oleh masyarakat.

Konsep kebidanan transkultural menjadi sangat penting dalam menjembatani perbedaan budaya antara tenaga kesehatan dan pasien. Melalui pendekatan ini, bidan diharapkan mampu memberikan asuhan yang holistik, humanis, dan berpusat pada kebutuhan individu dengan tetap mempertimbangkan aspek budaya yang melatarbelakanginya. Buku ini disusun untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep dasar kebidanan transkultural, teori-teori yang mendasari, serta penerapannya dalam praktik kebidanan di masyarakat multikultural Indonesia.

Materi dalam buku ini mencakup berbagai aspek penting, mulai dari konsep budaya dalam kesehatan, komunikasi lintas budaya, kepercayaan tradisional terkait kehamilan dan persalinan, hingga tantangan dan strategi dalam memberikan pelayanan kebidanan yang sensitif budaya. Selain itu, buku ini juga dilengkapi dengan contoh kasus dan pembahasan yang diharapkan dapat membantu pembaca dalam memahami penerapan konsep secara nyata di lapangan.

Penulis berharap buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa kebidanan, tenaga kesehatan, pendidik, serta praktisi kebidanan dalam meningkatkan kompetensi dan kualitas pelayanan. Lebih dari itu, buku ini diharapkan dapat berkontribusi dalam menciptakan pelayanan kebidanan yang lebih inklusif, menghargai keberagaman, serta mampu meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak di Indonesia.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan dan penyempurnaan di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan kontribusi dalam proses penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang luas serta menjadi salah satu kontribusi positif dalam pengembangan ilmu dan praktik kebidanan di Indonesia.

Penulis

Mei, 2026

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
---------------------	------------

DAFTAR ISI.....	v
------------------------	----------

BAB I TEORI KEBIDANAN TRANSKULTURAL..... 1

A. Pendahuluan.....	1
B. Konsep Dasar Kebidanan Transkultural	1
C. Budaya dan Determinan Sosial dalam Kesehatan Ibu dan Anak.....	4
D. Teori dan Model Kebidanan Transkultural	6
E. Kompetensi Budaya dalam Praktik Kebidanan	8
F. Praktik Budaya dalam Kesehatan Ibu dan Anak di Indonesia	11
G. Pendekatan Transkultural dalam Asuhan Kebidanan	12
H. Tantangan, Etika, dan Implikasi Kebidanan Transkultural.....	14
I. Penutup	17
Referensi.....	18

BAB II KEPERCAYAAN DAN PRAKTIK TRADISIONAL DALAM KEHAMILAN DAN PERSALINAN21

A. Pendahuluan.....	21
B. Kepercayaan Tradisional pada Masa Kehamilan	22
C. Kepercayaan dan Praktik Tradisional Saat Persalinan	25
D. Nilai Positif dan Risiko Kesehatan.....	27
E. Implikasi bagi Praktik Kebidanan.....	29
F. Perspektif Kebidanan dan Integrasi Pelayanan Sensitif Budaya	30
G. Simpulan	32
Referensi.....	32

BAB III PENGARUH BUDAYA TERHADAP KEPUTUSAN PERSALINAN.....35

A. Pendahuluan.....	35
B. Konsep Budaya Dalam Kesehatan maternal	36
C. Persepsi dan Kepercayaan Budaya tentang Persalinan	37
D. Pengambilan Keputusan Persalinan dalam Konteks Budaya	39
E. Praktik Budaya dalam Persalinan	40
F. Dampak Budaya terhadap Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan	41

G. Peran Bidan dalam Menghadapi Pengaruh Budaya terhadap keputusan persalinan	43
H. Contoh Kasus (Kontekstual Indonesia Timur).....	45
I. Penutup	46
Referensi.....	47
 BAB IV KOMUNIKASI TERAPEUTIK PADA IBU DAN KELUARGA	51
A. Pendahuluan.....	51
B. Komunikasi Terapeutik Pada Ibu dan Keluarga.....	52
C. Penutup	59
Referensi.....	60
 BAB V INTEGRASI PRAKTIK TRADISONAL DAN KLINIS.....	63
A. Pendahuluan.....	63
B. Konsep Dasar Integrasi Praktik Tradisonal Dan Klinis	64
C. Identifikasi Praktik Tradisional Dalam Kebidanan (Analisis Keamanan dan Evidence)	75
D. Penutup	79
Referensi.....	80
 PROFIL PENULIS	83

BAB I

TEORI KEBIDANAN TRANSKULTURAL

A. Pendahuluan

Pendekatan transkultural dalam kebidanan merupakan respons terhadap meningkatnya keberagaman budaya dalam masyarakat yang memengaruhi perilaku kesehatan ibu dan anak. Budaya tidak hanya membentuk cara individu memaknai kehamilan, persalinan, masa nifas, dan perawatan bayi, tetapi juga menentukan pilihan dalam mencari dan menerima pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, bidan sebagai tenaga profesional dituntut untuk mampu memberikan asuhan yang tidak hanya berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan keterampilan klinis, tetapi juga sensitif terhadap nilai, kepercayaan, serta praktik budaya yang dianut oleh pasien. Pendekatan ini menjadi penting dalam menciptakan pelayanan yang efektif, humanis, dan berorientasi pada kebutuhan pasien.

Dalam praktiknya, kebidanan transkultural menghadirkan berbagai tantangan, terutama ketika terjadi perbedaan antara nilai budaya pasien dengan prinsip kesehatan modern. Kondisi ini menuntut bidan untuk memiliki kompetensi dalam komunikasi lintas budaya, pengambilan keputusan etik, serta kemampuan beradaptasi dalam situasi yang kompleks. Selain itu, pendekatan transkultural juga memiliki implikasi yang luas dalam pendidikan, praktik klinik, dan pelayanan komunitas. Dengan mengintegrasikan aspek budaya dalam pelayanan kesehatan, diharapkan kualitas asuhan kebidanan dapat meningkat serta mampu menjangkau masyarakat secara lebih inklusif dan berkeadilan.

B. Konsep Dasar Kebidanan Transkultural

1. Pengertian Kebidanan Transkultural

Kebidanan transkultural merupakan pendekatan dalam praktik kebidanan yang menempatkan budaya sebagai komponen esensial dalam pemberian asuhan kepada perempuan, bayi, dan keluarga. Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada aspek biologis, tetapi juga mengintegrasikan nilai, kepercayaan, norma, dan praktik budaya yang dianut oleh individu maupun komunitas. Dalam konteks ini, budaya dipahami sebagai faktor yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi persepsi kesehatan, perilaku pencarian pelayanan, serta penerimaan terhadap intervensi medis.

Seiring dengan berkembangnya paradigma pelayanan kesehatan yang berorientasi pada pasien (*patient-centered care*), kebidanan transkultural menjadi semakin relevan. Pendekatan ini menekankan pentingnya pemberian asuhan yang selaras dengan nilai budaya pasien (*culturally congruent care*), sehingga dapat meningkatkan kualitas interaksi antara bidan dan pasien. Hasil kajian sistematis menunjukkan bahwa keberagaman budaya dalam pelayanan maternitas berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan apabila diakomodasi secara tepat dalam praktik klinik (Iswanti et al., 2024).

Dengan demikian, kebidanan transkultural dapat dipahami sebagai pendekatan holistik yang menggabungkan ilmu kebidanan dengan pemahaman budaya untuk menghasilkan pelayanan yang efektif, aman, dan bermakna bagi pasien dalam konteks sosial budaya yang spesifik.

2. Ruang Lingkup dan Tujuan

Kebidanan transkultural memiliki ruang lingkup yang luas, mencakup seluruh siklus kehidupan reproduksi perempuan, mulai dari masa prakonsepsi, kehamilan, persalinan, masa nifas, hingga perawatan bayi baru lahir dan keluarga berencana. Pada setiap tahap tersebut, bidan diharapkan mampu mengidentifikasi dan memahami praktik budaya yang berkembang di masyarakat, seperti pantangan makanan selama kehamilan, ritual persalinan, hingga pola perawatan bayi yang berbasis tradisi lokal.

Selain aspek klinis, ruang lingkup kebidanan transkultural juga meliputi komunikasi lintas budaya, pengambilan keputusan berbasis keluarga, serta integrasi praktik tradisional dengan pelayanan kesehatan modern. Hal ini menunjukkan bahwa peran bidan tidak hanya sebagai pemberi layanan medis, tetapi juga sebagai fasilitator yang menjembatani antara sistem kesehatan formal dengan nilai budaya masyarakat.

Tujuan utama kebidanan transkultural adalah untuk menghasilkan asuhan kebidanan yang tidak hanya efektif secara klinis, tetapi juga dapat diterima secara budaya oleh pasien dan keluarganya. Pendekatan ini bertujuan meningkatkan kepatuhan terhadap pelayanan kesehatan, mengurangi konflik budaya, serta mendukung tercapainya hasil kesehatan ibu dan bayi yang optimal. Dalam konteks pelayanan berkelanjutan (*continuity of care*), integrasi aspek budaya terbukti berperan dalam meningkatkan kualitas asuhan kebidanan secara menyeluruh (Lestari & Hanum, 2025).

3. Urgensi dalam Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

Urgensi kebidanan transkultural semakin nyata dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia, yang memiliki keragaman etnis, bahasa, dan sistem kepercayaan. Tingginya angka kematian ibu dan bayi tidak hanya

dipengaruhi oleh faktor medis, tetapi juga oleh faktor sosial budaya yang kompleks. Kepercayaan terhadap praktik tradisional, peran keluarga dalam pengambilan keputusan, serta persepsi terhadap tenaga kesehatan merupakan determinan penting dalam pemanfaatan layanan kesehatan.

Berbagai studi menunjukkan bahwa ketidaksesuaian antara pelayanan kesehatan dengan nilai budaya pasien dapat menyebabkan rendahnya akses dan pemanfaatan layanan, bahkan penolakan terhadap intervensi medis. Sebaliknya, pelayanan yang sensitif terhadap budaya mampu meningkatkan kepercayaan pasien, memperkuat hubungan terapeutik, dan mendorong partisipasi aktif dalam perawatan.

Selain itu, pelayanan kebidanan yang tidak mempertimbangkan aspek budaya berpotensi menimbulkan kesenjangan pelayanan dan ketidakpuasan pasien. Oleh karena itu, integrasi pendekatan transkultural menjadi strategi penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak secara komprehensif, terutama dalam upaya menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu serta bayi (Ummah et al., 2025).

4. Perbedaan Pendekatan Konvensional dan Transkultural

Pendekatan kebidanan konvensional pada umumnya berfokus pada aspek biomedis, dengan penekanan pada diagnosis dan intervensi klinis. Dalam pendekatan ini, budaya sering kali dipandang sebagai faktor eksternal yang tidak secara langsung memengaruhi proses pelayanan. Akibatnya, interaksi antara tenaga kesehatan dan pasien cenderung bersifat satu arah, dengan dominasi keputusan berada pada tenaga kesehatan.

Sebaliknya, pendekatan kebidanan transkultural mengedepankan perspektif holistik yang mencakup dimensi biologis, psikologis, sosial, dan budaya. Budaya tidak lagi dipandang sebagai hambatan, melainkan sebagai bagian integral yang perlu dipahami dan diakomodasi dalam proses asuhan. Komunikasi dalam pendekatan ini bersifat dua arah dan partisipatif, dengan melibatkan pasien serta keluarga dalam pengambilan keputusan.

Perbedaan mendasar antara kedua pendekatan tersebut terletak pada cara pandang terhadap pasien. Pendekatan konvensional cenderung melihat pasien sebagai objek pelayanan, sedangkan pendekatan transkultural memandang pasien sebagai individu yang memiliki nilai, kepercayaan, dan konteks budaya yang unik. Penelitian menunjukkan bahwa kompetensi budaya tenaga kesehatan berhubungan dengan peningkatan kualitas komunikasi terapeutik dan keselamatan pasien dalam pelayanan Kesehatan (Yusnaini et al., 2024).

Dengan demikian, pendekatan transkultural tidak menggantikan pendekatan medis, tetapi melengkapinya, sehingga pelayanan kebidanan

menjadi lebih humanis, kontekstual, dan berorientasi pada kebutuhan pasien secara menyeluruh.

C. Budaya dan Determinan Sosial dalam Kesehatan Ibu dan Anak

1. Definisi Budaya dan Unsur-unsurnya

Budaya merupakan suatu sistem kompleks yang mencakup nilai, kepercayaan, norma, pengetahuan, serta praktik yang dipelajari dan diwariskan dari generasi ke generasi dalam suatu kelompok masyarakat. Dalam konteks kesehatan, budaya berfungsi sebagai kerangka acuan yang membentuk cara individu memaknai konsep sehat dan sakit, sekaligus menentukan perilaku dalam menjaga kesehatan.

Unsur-unsur budaya yang berperan dalam kesehatan ibu dan anak meliputi nilai (values), norma (norms), kepercayaan (beliefs), tradisi (traditions), serta praktik sosial yang berkembang dalam komunitas. Unsur-unsur tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling berinteraksi dan membentuk pola perilaku yang khas pada setiap kelompok masyarakat. Dalam praktik kebidanan, perbedaan budaya ini menjadi faktor penting yang memengaruhi pengalaman kehamilan, persalinan, nifas, hingga perawatan bayi.

Kajian terbaru menunjukkan bahwa keberagaman budaya dalam pelayanan maternitas harus dipahami sebagai bagian integral dalam peningkatan kualitas pelayanan, karena budaya memengaruhi persepsi pasien terhadap pelayanan kesehatan serta interaksi dengan tenaga Kesehatan (Iswanti et al., 2024).

2. Determinan Sosial Budaya dalam Kesehatan

Kesehatan ibu dan anak dipengaruhi oleh berbagai determinan sosial budaya yang saling berkaitan. Determinan ini mencakup kondisi sosial, ekonomi, pendidikan, lingkungan, serta sistem nilai yang dianut oleh individu dan masyarakat. Faktor-faktor tersebut berperan dalam menentukan akses terhadap pelayanan kesehatan, kualitas perawatan, serta hasil kesehatan ibu dan bayi.

Organisasi kesehatan global seperti World Health Organization menekankan bahwa determinan sosial merupakan faktor utama yang menyebabkan ketimpangan kesehatan antar kelompok masyarakat. Determinan ini mencakup distribusi sumber daya, akses layanan kesehatan, serta kondisi sosial yang memengaruhi kehidupan sehari-hari individu.

Dalam konteks kebidanan, determinan sosial budaya dapat terlihat pada tingkat pendidikan ibu, status ekonomi keluarga, serta dukungan sosial dari lingkungan sekitar. Ibu dengan akses informasi yang terbatas cenderung mengalami keterlambatan dalam mengenali tanda bahaya kehamilan, sedangkan keterbatasan ekonomi dapat menghambat akses terhadap fasilitas kesehatan

yang memadai. Oleh karena itu, pendekatan kebidanan harus mempertimbangkan determinan sosial budaya sebagai bagian dari pengkajian komprehensif.

3. Pengaruh Budaya terhadap Perilaku Kehamilan, Persalinan, Nifas, dan Bayi

Budaya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku kesehatan pada setiap tahap siklus reproduksi perempuan. Pada masa kehamilan, berbagai praktik budaya seperti pantangan makanan, pembatasan aktivitas, serta ritual tertentu sering kali dijalankan oleh ibu hamil. Praktik ini dapat memberikan manfaat psikologis, namun juga berpotensi menimbulkan dampak negatif apabila tidak sesuai dengan prinsip kesehatan.

Pada proses persalinan, budaya memengaruhi pilihan tempat persalinan, posisi melahirkan, serta penolong persalinan. Dalam beberapa masyarakat, persalinan di rumah masih dipilih karena dianggap lebih sesuai dengan nilai budaya dan memberikan rasa nyaman bagi ibu. Sementara itu, pada masa nifas, praktik seperti masa pantang, penggunaan ramuan tradisional, serta pembatasan aktivitas masih banyak dijumpai.

Budaya juga berperan dalam perawatan bayi baru lahir, termasuk praktik pemberian ASI, perawatan tali pusat, serta pola pengasuhan. Perbedaan latar belakang budaya antara pasien dan tenaga kesehatan dapat memengaruhi komunikasi dan kualitas pelayanan. Studi menunjukkan bahwa ketidaksesuaian budaya dapat menurunkan kepercayaan terhadap layanan kesehatan dan berdampak pada hasil kesehatan ibu dan bayi (Iswanti et al., 2024).

4. Budaya sebagai Faktor Risiko dan Protektif

Budaya dalam kesehatan ibu dan anak memiliki peran ganda, yaitu sebagai faktor protektif dan faktor risiko. Sebagai faktor protektif, budaya dapat memberikan dukungan sosial yang kuat, memperkuat peran keluarga dalam perawatan, serta menyediakan mekanisme adaptasi psikologis bagi ibu selama kehamilan dan persalinan. Nilai-nilai kebersamaan dalam budaya tertentu dapat meningkatkan kesejahteraan emosional ibu.

Namun demikian, budaya juga dapat menjadi faktor risiko apabila praktik yang dilakukan tidak sesuai dengan prinsip kesehatan. Contohnya adalah pantangan makanan yang menyebabkan kekurangan nutrisi, keterlambatan dalam mencari pertolongan medis, serta praktik persalinan yang tidak aman. Dalam kondisi ini, budaya dapat berkontribusi terhadap meningkatnya risiko komplikasi pada ibu dan bayi.

Pendekatan kebidanan transkultural menekankan pentingnya keseimbangan antara penghormatan terhadap budaya dan penerapan praktik berbasis bukti. Tenaga kesehatan dituntut untuk mampu melakukan negosiasi

budaya secara efektif, sehingga praktik yang bermanfaat dapat dipertahankan, sementara praktik yang berisiko dapat dimodifikasi. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang menegaskan bahwa pelayanan maternitas yang sensitif budaya mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan hasil kesehatan secara keseluruhan (Iswanti et al., 2024).

D. Teori dan Model Kebidanan Transkultural

1. Teori Culture Care Diversity and Universality – Madeleine Leininger

Teori *Culture Care Diversity and Universality* merupakan fondasi utama dalam pengembangan kebidanan transkultural. Teori ini dikemukakan oleh Madeleine Leininger, seorang pelopor keperawatan transkultural yang mengintegrasikan ilmu keperawatan dengan antropologi budaya. Leininger menegaskan bahwa praktik asuhan kesehatan tidak dapat dipisahkan dari nilai, kepercayaan, dan praktik budaya yang dianut oleh individu maupun kelompok. Oleh karena itu, pemahaman terhadap budaya menjadi elemen esensial dalam memberikan pelayanan kesehatan yang efektif dan bermakna.

Konsep utama dalam teori ini adalah *culturally congruent care*, yaitu pelayanan kesehatan yang selaras dengan nilai dan budaya pasien. Leininger menjelaskan bahwa setiap budaya memiliki keragaman (*diversity*) sekaligus kesamaan universal (*universality*) dalam praktik perawatan. Dengan demikian, tenaga kesehatan, termasuk bidan, perlu mampu mengidentifikasi praktik budaya yang dapat dipertahankan, dimodifikasi, atau diubah agar tetap selaras dengan prinsip kesehatan. Teori ini menjadi landasan penting dalam praktik kebidanan modern karena mendorong pelayanan yang tidak hanya berorientasi pada aspek klinis, tetapi juga menghargai dimensi sosial dan budaya pasien (Leininger, 2002).

2. Model Sunrise dalam Praktik Kebidanan

Model Sunrise merupakan representasi visual dari teori Leininger yang menggambarkan hubungan kompleks antara berbagai faktor yang memengaruhi kesehatan individu. Model ini menampilkan berbagai komponen seperti faktor teknologi, agama dan filosofi hidup, struktur sosial dan keluarga, nilai budaya, sistem politik dan hukum, serta kondisi ekonomi yang secara bersama-sama membentuk perilaku kesehatan seseorang.

Dalam praktik kebidanan, Model Sunrise berfungsi sebagai kerangka pengkajian komprehensif untuk memahami latar belakang ibu dan keluarga secara holistik. Melalui pendekatan ini, bidan dapat mengidentifikasi faktor budaya yang memengaruhi keputusan terkait kehamilan, persalinan, nifas, dan perawatan bayi. Misalnya, kepercayaan terhadap praktik tradisional, peran

keluarga dalam pengambilan keputusan, serta kondisi sosial ekonomi yang memengaruhi akses terhadap pelayanan kesehatan.

Penggunaan Model Sunrise memungkinkan integrasi antara pendekatan biomedis dan pendekatan budaya dalam pelayanan kesehatan. Hal ini sangat penting dalam konteks masyarakat multikultural seperti Indonesia, di mana keberagaman budaya memengaruhi cara individu memaknai kesehatan dan penyakit. Dengan memahami berbagai faktor tersebut, bidan dapat memberikan asuhan yang lebih kontekstual, meningkatkan kepercayaan pasien, serta meminimalkan konflik budaya dalam pelayanan Kesehatan (Ulutaşdemir, 2023).

3. Konsep Cultural Competence dan Cultural Humility

Seiring dengan perkembangan pelayanan kesehatan global, konsep *cultural competence* menjadi bagian penting dalam praktik kebidanan transkultural. *Cultural competence* merujuk pada kemampuan tenaga kesehatan untuk memahami, menghargai, dan merespons perbedaan budaya secara efektif dalam pelayanan kesehatan. Kompetensi ini mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, serta sikap dalam berinteraksi dengan pasien dari latar belakang budaya yang beragam.

Namun demikian, perkembangan teori transkultural menunjukkan bahwa *cultural competence* saja belum cukup untuk menjawab kompleksitas interaksi budaya dalam pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, muncul konsep *cultural humility* yang menekankan pentingnya refleksi diri, kesadaran akan keterbatasan pengetahuan, serta sikap terbuka terhadap pengalaman budaya pasien. Pendekatan ini mendorong tenaga kesehatan untuk membangun hubungan yang setara dengan pasien, bukan sekadar menjadi “ahli budaya”, tetapi sebagai mitra dalam proses perawatan.

Dalam praktik kebidanan, penerapan *cultural humility* memungkinkan bidan untuk lebih sensitif terhadap kebutuhan pasien, menghindari stereotip budaya, serta meningkatkan kualitas komunikasi terapeutik. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip pelayanan kesehatan modern yang berorientasi pada pasien (*patient-centered care*), di mana nilai, preferensi, dan pengalaman pasien menjadi bagian integral dalam pengambilan keputusan klinis (Moral et al., 2023).

4. Perkembangan Teori Transkultural dalam Pelayanan Kesehatan Modern

Perkembangan teori kebidanan transkultural tidak terlepas dari dinamika globalisasi, mobilitas penduduk, serta meningkatnya interaksi antarbudaya dalam masyarakat. Sejak pertama kali diperkenalkan oleh Leininger pada pertengahan abad ke-20, teori transkultural terus berkembang dan mengalami adaptasi sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan modern. Hal ini menunjukkan bahwa

pendekatan transkultural bersifat dinamis dan responsif terhadap perubahan sosial.

Dalam konteks pelayanan kesehatan saat ini, teori transkultural telah terintegrasi dengan pendekatan *evidence-based practice* dan *patient-centered care*. Integrasi ini menekankan bahwa pelayanan kesehatan yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh efektivitas klinis, tetapi juga oleh kemampuan tenaga kesehatan dalam memahami konteks budaya pasien. Pendekatan ini terbukti dapat meningkatkan kepuasan pasien, memperkuat hubungan terapeutik serta mengurangi kesenjangan dalam akses dan kualitas pelayanan kesehatan.

Selain itu, perkembangan teori transkultural juga ditandai dengan munculnya berbagai model kompetensi budaya yang memperkaya praktik pelayanan kesehatan. Model-model tersebut tetap berakar pada teori Leininger, namun dikembangkan lebih lanjut untuk menyesuaikan dengan kebutuhan praktik modern yang semakin kompleks. Dengan demikian, kebidanan transkultural menjadi salah satu pendekatan strategis dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat multicultural (Moral et al., 2023).

E. Kompetensi Budaya dalam Praktik Kebidanan

1. Prinsip Asuhan Kebidanan Berbasis Budaya

Pendekatan transkultural dalam asuhan kebidanan berangkat dari pemahaman bahwa budaya merupakan faktor fundamental yang memengaruhi cara individu memaknai kesehatan, kehamilan, persalinan, dan perawatan bayi. Oleh karena itu, pelayanan kebidanan yang berkualitas harus mampu mengintegrasikan nilai, kepercayaan, dan praktik budaya pasien ke dalam proses asuhan. Prinsip utama dalam pendekatan ini adalah pemberian asuhan yang bersifat *culturally congruent*, yaitu asuhan yang selaras dengan nilai budaya pasien serta relevan dengan kebutuhan dan konteks kehidupannya.

Asuhan kebidanan berbasis budaya tidak hanya berfokus pada penghormatan terhadap perbedaan budaya, tetapi juga menekankan pentingnya pemahaman mendalam terhadap dinamika budaya yang memengaruhi perilaku kesehatan. Konsep *culturally congruent care* dijelaskan sebagai proses interaktif antara tenaga kesehatan dan pasien untuk mencapai kesesuaian antara praktik profesional dengan kebutuhan budaya pasien. Pendekatan ini menuntut bidan untuk memiliki kesadaran diri terhadap nilai dan bias budaya yang dimilikinya, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan budaya pasien secara fleksibel dan reflektif (Agga et al., 2022).

Dalam praktik kebidanan, prinsip ini diwujudkan melalui kemampuan bidan dalam mengidentifikasi praktik budaya yang mendukung kesehatan, mempertahankan nilai budaya yang positif, serta melakukan penyesuaian terhadap praktik yang berpotensi menimbulkan risiko. Pendekatan ini juga menekankan pentingnya hubungan terapeutik yang didasarkan pada rasa saling percaya dan penghormatan. Dengan demikian, asuhan kebidanan berbasis budaya tidak hanya meningkatkan penerimaan pasien terhadap pelayanan kesehatan, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas dan keselamatan pelayanan secara keseluruhan (Domaradzki et al., 2024).

2. Komunikasi Efektif Lintas Budaya

Komunikasi merupakan aspek fundamental dalam asuhan kebidanan transkultural, terutama dalam menghadapi pasien dengan latar belakang budaya yang beragam. Perbedaan bahasa, nilai, norma, serta gaya komunikasi dapat menjadi hambatan dalam interaksi antara tenaga kesehatan dan pasien. Ketidaksesuaian dalam komunikasi ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman, menurunkan kepercayaan pasien, serta menghambat keberhasilan intervensi kesehatan.

Komunikasi lintas budaya yang efektif menuntut kemampuan bidan untuk tidak hanya menyampaikan informasi secara jelas, tetapi juga memahami makna yang terkandung dalam komunikasi pasien. Hal ini mencakup penggunaan bahasa yang sederhana, pemanfaatan penerjemah jika diperlukan, serta kemampuan untuk membaca komunikasi nonverbal yang sering kali dipengaruhi oleh budaya. Selain itu, sikap empati, penghormatan, serta keterbukaan terhadap perbedaan budaya menjadi kunci dalam membangun hubungan terapeutik yang efektif.

Penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi transkultural seperti penggunaan interpreter, peningkatan keterampilan komunikasi, serta refleksi diri tenaga kesehatan sangat penting dalam meningkatkan efektivitas komunikasi dengan pasien multikultural. Pendekatan ini memungkinkan tenaga kesehatan untuk lebih memahami kebutuhan pasien serta memberikan pelayanan yang lebih responsif dan bermakna (Wulandari et al., 2022).

3. Negosiasi dan Adaptasi Budaya dalam Pelayanan

Dalam praktik kebidanan, sering kali ditemukan situasi di mana praktik budaya pasien tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip kesehatan modern. Dalam kondisi tersebut, bidan perlu melakukan proses negosiasi dan adaptasi budaya sebagai bagian dari pendekatan transkultural. Negosiasi budaya merupakan proses dialog antara bidan dan pasien untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, sedangkan adaptasi budaya

mengacu pada penyesuaian intervensi kesehatan agar tetap relevan dengan konteks budaya pasien.

Pendekatan ini memerlukan keterampilan komunikasi yang efektif, pemahaman budaya yang mendalam, serta kemampuan untuk memberikan edukasi kesehatan secara persuasif. Bidan harus mampu menjelaskan risiko dan manfaat dari suatu tindakan kesehatan dengan cara yang dapat dipahami oleh pasien, tanpa mengabaikan nilai budaya yang dianutnya. Dalam hal ini, pendekatan yang digunakan tidak bersifat memaksakan, tetapi lebih mengedepankan dialog dan kolaborasi.

Proses negosiasi dan adaptasi budaya juga berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan pasien terhadap intervensi kesehatan. Ketika pasien merasa dihargai dan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, mereka cenderung lebih menerima dan menjalankan anjuran yang diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan transkultural tidak hanya berorientasi pada aspek budaya, tetapi juga pada peningkatan kualitas pelayanan secara keseluruhan.

4. Integrasi Budaya dengan Evidence-Based Practice

Perkembangan pelayanan kesehatan modern menuntut integrasi antara pendekatan budaya dengan *evidence-based practice*. Pendekatan ini menekankan bahwa keputusan klinis harus didasarkan pada bukti ilmiah terbaik, pengalaman klinis tenaga kesehatan, serta nilai dan preferensi pasien, termasuk aspek budaya. Dengan demikian, budaya tidak dipandang sebagai hambatan, tetapi sebagai komponen penting yang harus diintegrasikan dalam praktik berbasis bukti.

Integrasi ini menjadi tantangan sekaligus peluang dalam praktik kebidanan. Di satu sisi, bidan harus memastikan bahwa intervensi yang diberikan sesuai dengan standar ilmiah dan aman bagi pasien. Di sisi lain, bidan juga harus mempertimbangkan nilai budaya pasien agar intervensi tersebut dapat diterima dan dijalankan dengan baik. Pendekatan ini membutuhkan kemampuan analisis kritis serta fleksibilitas dalam pengambilan keputusan klinis.

Literatur menunjukkan bahwa kompetensi budaya merupakan bagian penting dari praktik berbasis bukti, karena dapat meningkatkan kualitas pelayanan serta mengurangi kesenjangan kesehatan pada populasi multikultural. Dengan mengintegrasikan budaya dalam *evidence-based practice*, bidan dapat memberikan asuhan yang tidak hanya efektif secara klinis, tetapi juga relevan secara sosial dan budaya (Engebretson et al., 2008).

F. Praktik Budaya dalam Kesehatan Ibu dan Anak di Indonesia

1. Keberagaman budaya masyarakat Indonesia

Indonesia dikenal sebagai negara dengan keragaman budaya yang sangat kompleks, yang tercermin dari variasi suku, adat istiadat, serta sistem nilai yang berkembang di masyarakat. Keberagaman ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik kesehatan, khususnya dalam kesehatan ibu dan anak. Setiap daerah memiliki kebiasaan yang berbeda dalam menghadapi kehamilan, persalinan, masa nifas, hingga perawatan bayi, yang semuanya dipengaruhi oleh nilai budaya lokal.

Penelitian menunjukkan bahwa kondisi kesehatan ibu tidak dapat dilepaskan dari konteks budaya masyarakat setempat, di mana setiap wilayah memiliki praktik dan kebiasaan yang berbeda dalam merawat kehamilan hingga persalinan. Variasi ini mencerminkan adanya hubungan yang erat antara budaya dan perilaku kesehatan masyarakat, sehingga pelayanan kesehatan perlu mempertimbangkan aspek budaya sebagai bagian dari pendekatan yang komprehensif (Rabiatunnisa et al., 2023).

2. Mitos, kepercayaan, dan praktik tradisional

Mitos dan kepercayaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari praktik budaya dalam kesehatan ibu dan anak di Indonesia. Berbagai kepercayaan terkait pantangan makanan, penggunaan ramuan tradisional, serta ritual tertentu masih banyak dijumpai dalam masyarakat, terutama di daerah dengan pengaruh budaya yang kuat. Praktik ini sering kali diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat meyakini praktik budaya dalam perawatan ibu, khususnya pada masa nifas, memiliki manfaat kesehatan, meskipun dalam beberapa kasus bertentangan dengan prinsip medis modern. Kurangnya pengetahuan serta kuatnya nilai budaya menyebabkan praktik tersebut tetap dipertahankan, bahkan ketika berpotensi menimbulkan risiko Kesehatan (Hertaty et al., 2023).

Selain itu, praktik budaya seperti pantangan makanan selama kehamilan dan masa menyusui juga terbukti dapat memengaruhi status gizi ibu dan anak. Pola makan yang tidak seimbang akibat kepercayaan budaya dapat meningkatkan risiko masalah gizi, termasuk stunting pada anak (Ardianti, 2023).

3. Peran keluarga dan komunitas dalam pengambilan keputusan

Dalam masyarakat Indonesia, pengambilan keputusan terkait kesehatan ibu dan anak tidak hanya dilakukan oleh individu, tetapi juga melibatkan keluarga dan komunitas. Struktur sosial yang kolektif menyebabkan keputusan kesehatan sering kali dipengaruhi oleh suami, orang tua, maupun tokoh masyarakat. Hal ini

menunjukkan bahwa perilaku kesehatan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu, tetapi juga oleh sistem sosial dan budaya yang lebih luas.

Penelitian etnografi menunjukkan bahwa sistem sosial budaya dalam masyarakat menjadi faktor penting dalam menentukan perilaku kesehatan ibu dan anak. Nilai-nilai yang dianut dalam keluarga dan komunitas dapat memengaruhi keputusan terkait pemanfaatan layanan kesehatan, termasuk pemilihan tempat persalinan dan penggunaan tenaga kesehatan profesional (Salsabila et al., 2022).

Selain itu, studi pada masyarakat adat menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan, persepsi, dan pendidikan yang dipengaruhi oleh budaya turut menentukan perilaku kesehatan ibu, termasuk dalam pemenuhan gizi anak. Hal ini menegaskan bahwa intervensi kesehatan perlu melibatkan keluarga dan komunitas sebagai bagian dari strategi peningkatan kesehatan Masyarakat (Dewi et al., 2020).

4. Analisis praktik budaya: bermanfaat vs berisiko

Mitos dan kepercayaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari praktik budaya dalam kesehatan ibu dan anak di Indonesia. Berbagai kepercayaan terkait pantangan makanan, penggunaan ramuan tradisional, serta ritual tertentu masih banyak dijumpai dalam masyarakat, terutama di daerah dengan pengaruh budaya yang kuat. Praktik ini sering kali diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat meyakini praktik budaya dalam perawatan ibu, khususnya pada masa nifas, memiliki manfaat kesehatan, meskipun dalam beberapa kasus bertentangan dengan prinsip medis modern. Kurangnya pengetahuan serta kuatnya nilai budaya menyebabkan praktik tersebut tetap dipertahankan, bahkan ketika berpotensi menimbulkan risiko Kesehatan (Hertaty et al., 2023).

Selain itu, praktik budaya seperti pantangan makanan selama kehamilan dan masa menyusui juga terbukti dapat memengaruhi status gizi ibu dan anak. Pola makan yang tidak seimbang akibat kepercayaan budaya dapat meningkatkan risiko masalah gizi, termasuk stunting pada anak (Ardianti, 2023).

G. Pendekatan Transkultural dalam Asuhan Kebidanan

1. Prinsip asuhan kebidanan berbasis budaya

Pendekatan transkultural dalam asuhan kebidanan berlandaskan pada pemahaman bahwa budaya merupakan determinan penting yang memengaruhi perilaku kesehatan ibu dan anak. Oleh karena itu, pelayanan kebidanan harus mampu mengakomodasi nilai, kepercayaan, serta praktik budaya pasien sebagai

bagian integral dari proses asuhan. Prinsip utama dalam pendekatan ini adalah pemberian asuhan yang selaras dengan budaya atau *culturally congruent care*, yaitu pelayanan yang tidak hanya memenuhi standar klinis, tetapi juga sesuai dengan konteks sosial budaya pasien.

Konsep ini menekankan bahwa keberhasilan asuhan kebidanan tidak hanya ditentukan oleh ketepatan tindakan medis, tetapi juga oleh kemampuan bidan dalam membangun hubungan yang harmonis dengan pasien. Penelitian menunjukkan bahwa pendekatan berbasis budaya dapat meningkatkan kepuasan pasien, memperkuat kepercayaan terhadap tenaga kesehatan, serta meningkatkan kepatuhan terhadap intervensi kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi budaya dalam praktik kebidanan merupakan kebutuhan yang tidak dapat diabaikan dalam pelayanan kesehatan modern (Moral et al., 2023).

2. Komunikasi efektif lintas budaya

Komunikasi lintas budaya merupakan aspek kunci dalam keberhasilan asuhan kebidanan transkultural. Perbedaan bahasa, norma, serta nilai budaya dapat menjadi hambatan dalam proses komunikasi antara bidan dan pasien. Oleh karena itu, kemampuan komunikasi yang sensitif terhadap budaya menjadi kompetensi penting yang harus dimiliki oleh tenaga kesehatan.

Komunikasi yang efektif tidak hanya berkaitan dengan penyampaian informasi, tetapi juga mencakup kemampuan memahami makna di balik pesan yang disampaikan oleh pasien. Hal ini melibatkan pemahaman terhadap komunikasi verbal dan nonverbal, penggunaan bahasa yang sederhana, serta kemampuan untuk menyesuaikan gaya komunikasi sesuai dengan latar belakang budaya pasien. Selain itu, sikap empati dan keterbukaan menjadi faktor penting dalam membangun hubungan terapeutik yang efektif.

Penelitian menunjukkan bahwa komunikasi lintas budaya yang baik dapat mengurangi kesalahpahaman, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memperkuat hubungan antara tenaga kesehatan dan pasien. Dengan demikian, komunikasi menjadi elemen penting dalam memastikan bahwa asuhan kebidanan dapat diterima dan dijalankan secara optimal oleh pasien (Wulandari et al., 2022).

3. Negosiasi dan adaptasi budaya dalam pelayanan

Dalam praktik kebidanan, sering kali terdapat perbedaan antara praktik budaya pasien dengan prinsip kesehatan modern. Dalam situasi tersebut, bidan perlu melakukan negosiasi dan adaptasi budaya sebagai bagian dari pendekatan transkultural. Negosiasi budaya merupakan proses dialog antara bidan dan pasien untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak,

sedangkan adaptasi budaya mengacu pada penyesuaian intervensi kesehatan agar sesuai dengan konteks budaya pasien.

Pendekatan ini menuntut keterampilan komunikasi yang efektif, pemahaman budaya yang mendalam, serta kemampuan untuk memberikan edukasi secara persuasif. Bidan perlu menjelaskan risiko dan manfaat dari suatu praktik kesehatan dengan cara yang mudah dipahami oleh pasien, tanpa mengabaikan nilai budaya yang dianutnya. Pendekatan yang digunakan harus bersifat kolaboratif, bukan otoritatif, sehingga pasien merasa dihargai dan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan negosiasi budaya dapat meningkatkan kepatuhan pasien terhadap intervensi kesehatan serta mengurangi resistensi terhadap pelayanan kesehatan modern. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan transkultural tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan, tetapi juga memperkuat hubungan antara tenaga kesehatan dan pasien (Wulandari et al., 2022).

4. Integrasi budaya dengan *evidence-based practice*

Perkembangan pelayanan kebidanan modern menuntut integrasi antara pendekatan budaya dengan *evidence-based practice*. Pendekatan ini menekankan bahwa keputusan klinis harus didasarkan pada bukti ilmiah terbaik, pengalaman klinis tenaga kesehatan, serta nilai dan preferensi pasien, termasuk aspek budaya. Dengan demikian, budaya tidak dipandang sebagai hambatan, tetapi sebagai komponen penting dalam pengambilan keputusan klinis.

Integrasi ini memungkinkan bidan untuk memberikan asuhan yang lebih komprehensif, tidak hanya efektif secara klinis tetapi juga relevan secara sosial dan budaya. Dalam praktiknya, bidan perlu melakukan analisis kritis terhadap praktik budaya pasien, serta mengintegrasikannya dengan intervensi berbasis bukti yang aman dan efektif. Pendekatan ini juga berperan dalam mengurangi kesenjangan pelayanan kesehatan pada masyarakat multikultural.

Penelitian menunjukkan bahwa kompetensi budaya merupakan bagian penting dari praktik berbasis bukti, karena dapat meningkatkan kualitas pelayanan serta hasil kesehatan pasien. Dengan demikian, integrasi budaya dalam *evidence-based practice* menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan mutu pelayanan kebidanan di era modern (Moral et al., 2023).

H. Tantangan, Etika, dan Implikasi Kebidanan Transkultural

1. Dilema etik dalam praktik berbasis budaya

Penerapan pendekatan transkultural dalam kebidanan tidak terlepas dari berbagai dilema etik yang muncul akibat perbedaan antara nilai budaya pasien

dan prinsip medis modern. Dalam praktiknya, bidan sering dihadapkan pada situasi di mana praktik budaya yang diyakini oleh pasien berpotensi bertentangan dengan standar keselamatan dan evidence-based practice. Kondisi ini menempatkan bidan dalam posisi yang kompleks, karena di satu sisi harus menghormati nilai budaya pasien, namun di sisi lain tetap memiliki tanggung jawab profesional untuk menjaga keselamatan ibu dan bayi.

Dilema etik ini sering muncul dalam konteks pengambilan keputusan klinis, seperti penolakan intervensi medis, praktik persalinan tradisional, atau penggunaan metode pengobatan nonmedis yang belum terbukti secara ilmiah. Dalam menghadapi situasi tersebut, bidan perlu mengedepankan prinsip etika kesehatan, seperti otonomi, beneficence, nonmaleficence, dan keadilan, sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Pendekatan yang digunakan harus bersifat dialogis, dengan mengedepankan komunikasi terbuka dan penghormatan terhadap nilai pasien, tanpa mengabaikan aspek keselamatan.

Penelitian menunjukkan bahwa dilema etik dalam pelayanan kesehatan multikultural memerlukan kemampuan refleksi etis serta sensitivitas budaya yang tinggi dari tenaga kesehatan. Oleh karena itu, penguatan kompetensi etik dan budaya menjadi hal yang penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan transcultural (Moral et al., 2023).

2. Tantangan pelayanan di masyarakat multikultural

Pelayanan kebidanan di masyarakat multikultural menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, terutama terkait dengan perbedaan bahasa, nilai budaya, serta tingkat pendidikan masyarakat. Perbedaan ini dapat memengaruhi komunikasi, pemahaman terhadap informasi kesehatan, serta kepatuhan terhadap anjuran medis. Selain itu, adanya kepercayaan terhadap praktik tradisional juga dapat menjadi hambatan dalam penerapan pelayanan kesehatan modern.

Tantangan lainnya adalah keterbatasan tenaga kesehatan dalam memahami keragaman budaya yang ada di masyarakat. Kurangnya pelatihan dan pengalaman dalam menghadapi pasien dengan latar belakang budaya yang berbeda dapat menyebabkan kesalahpahaman, bahkan konflik antara tenaga kesehatan dan pasien. Hal ini dapat berdampak pada kualitas pelayanan serta kepuasan pasien.

Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi budaya tenaga kesehatan, termasuk melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan, dapat membantu mengatasi tantangan tersebut. Selain itu, pendekatan kolaboratif yang melibatkan keluarga dan komunitas juga menjadi strategi penting dalam

meningkatkan efektivitas pelayanan kesehatan di masyarakat multicultural (Truong et al., 2014).

3. Peran bidan sebagai *cultural broker*

Dalam konteks kebidanan transkultural, bidan memiliki peran strategis sebagai *cultural broker*, yaitu pihak yang menjembatani perbedaan antara sistem kesehatan modern dengan nilai budaya pasien. Peran ini menuntut bidan untuk tidak hanya memahami aspek klinis, tetapi juga memiliki kemampuan dalam memahami dan menafsirkan nilai budaya pasien secara tepat.

Sebagai *cultural broker*, bidan berperan dalam memfasilitasi komunikasi antara pasien dan sistem kesehatan, membantu pasien memahami informasi medis, serta menyampaikan nilai budaya pasien kepada tenaga kesehatan lainnya. Peran ini juga mencakup kemampuan untuk melakukan negosiasi budaya, sehingga tercapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak tanpa mengorbankan keselamatan pasien.

Penelitian menunjukkan bahwa peran *cultural broker* sangat penting dalam meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, terutama pada kelompok masyarakat yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Dengan menjalankan peran ini secara efektif, bidan dapat membantu mengurangi kesenjangan pelayanan kesehatan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem Kesehatan (Alexander et al., 2020).

4. Implikasi dalam pendidikan, praktik klinik, dan pelayanan komunitas

Pendekatan transkultural dalam kebidanan memiliki implikasi yang luas, baik dalam pendidikan, praktik klinik, maupun pelayanan komunitas. Dalam pendidikan kebidanan, kompetensi budaya perlu diintegrasikan ke dalam kurikulum sebagai bagian dari pembelajaran profesional. Mahasiswa kebidanan perlu dibekali dengan pengetahuan, keterampilan, serta sikap yang mendukung pelayanan yang sensitif terhadap budaya.

Dalam praktik klinik, pendekatan transkultural menuntut bidan untuk mampu menerapkan prinsip *culturally congruent care* dalam setiap interaksi dengan pasien. Hal ini mencakup kemampuan dalam melakukan pengkajian budaya, komunikasi efektif, serta pengambilan keputusan yang mempertimbangkan aspek budaya pasien. Pendekatan ini juga berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan serta keselamatan pasien.

Sementara itu, dalam pelayanan komunitas, pendekatan transkultural menjadi sangat penting dalam merancang program kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Program kesehatan yang mempertimbangkan aspek budaya cenderung lebih diterima oleh masyarakat dan memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, integrasi pendekatan transkultural

dalam berbagai aspek pelayanan kebidanan menjadi strategi penting dalam meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak.

Penelitian menunjukkan bahwa integrasi kompetensi budaya dalam pendidikan dan praktik kesehatan dapat meningkatkan kualitas pelayanan serta mengurangi kesenjangan kesehatan pada masyarakat multikultural. Hal ini menegaskan bahwa pendekatan transkultural merupakan bagian penting dalam pengembangan sistem pelayanan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan (Moral et al., 2023).

I. Penutup

Pendekatan transkultural dalam kebidanan merupakan elemen penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak di tengah keberagaman budaya masyarakat. Dengan memahami dan mengintegrasikan nilai, kepercayaan, serta praktik budaya ke dalam asuhan kebidanan, bidan dapat memberikan pelayanan yang lebih efektif, aman, dan berorientasi pada pasien. Meskipun terdapat berbagai tantangan dan dilema etik dalam praktiknya, penerapan komunikasi lintas budaya, negosiasi yang tepat, serta integrasi dengan evidence-based practice menjadi kunci dalam mencapai asuhan yang optimal. Oleh karena itu, penguatan kompetensi budaya dalam pendidikan dan praktik kebidanan perlu terus dikembangkan sebagai upaya mewujudkan pelayanan kesehatan yang inklusif, berkeadilan, dan berkualitas.

Referensi

- Agga, A. O., Lavin, K. L., & Jr, R. B. A. (2022). Culturally Congruent Care in Nursing Practice : A Concept Analysis. *SSRG International Journal of Nursing and Health Science*, 8(3), 32–39. <https://doi.org/https://doi.org/10.14445/24547484/IJNHS-V8I3P106> Volume
- Alexander, S., Belue, R., Kuzmik, A., & Boltz, M. (2020). The evolution of cultural competence theories in American (United States) nursing curricula: An integrative review. *J Nurs Educ Pract.*, 10(12), 30–37. <https://doi.org/10.5430/jnep.v10n12p30>.The
- Ardianti, I. (2023). Budaya Yang Dimiliki Ibu Saat Hamil, Menyusui dan Merawat Balita Stunting. *Ilmu Kesehatan MAKIA*, 13(1), 14–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.37413/jmakia.v13i1.271>
- Dewi, R. K., Khomsan, A., Rosidi, A., Riyadi, H., & Margawati, A. (2020). PERILAKU GIZI-KESEHATAN IBU BALITA PADA MASYARAKAT ADAT SAMIN DI JAWA TENGAH. *Jurnal Kesehatan*, 11(3), 329–334. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35730/jk.v11i3.589>
- Domaradzki, J., Głodowska, K., Doron, E., Markwitz-grzyb, N., & Jabkowski, P. (2024). Cultural competences among future nurses and midwives : a case of attitudes toward Jehovah ' s witnesses ' stance on blood transfusion. *BMC Medical Education*, 24, 1–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.1186/s12909-024-05646-1>
- Engebretson, J., Mahoney, J., & Carlson, E. D. (2008). C ULTURAL C OMPETENCE IN THE E RA OF. *Journal of Professional Nursing*, 24(3), 172–178. <https://doi.org/10.1016/j.profnurs.2007.10.012>
- Hertaty, D., Natalia, V., & Stefanicia. (2023). The Effect of culture and Health Practices on Postpartum Mother in the River Watershed Area (DAS) in 2023. *Jurnal Surya Medika (JSM)*, 9(3).
- Iswanti, D. I., Erwansyah, R. A., Moh, I. M., Saifudin, Y., & Pujiyanto, T. I. (2024). Cultural diversity in maternity care in improving the quality of care services : a systematic review. *International Journal of Public Health Science (IJPHS)*, 13(3), 1258–1267. <https://doi.org/10.11591/ijphs.v13i3.24143>
- Leininger, M. (2002). *Transcultural nursing*. McGraw-Hill.
- Lestari, F. D., & Hanum, S. M. F. (2025). Continuity of Midwifery Care for Pregnancy, Childbirth, Postpartum, and Newborns : Kelanjutan Pelayanan Kebidanan untuk Kehamilan, Persalinan, Pasca Persalinan, dan Bayi Baru Lahir. *Indonesian Journal*

on Health Science and Medicine, 2(2), 1–10.
<https://doi.org/https://doi.org/10.21070/ijhsm.v2i2.277>

- Moral, J. M. L., Tosun, B., Ibáñez, R. G., Navarrete, L., & Yava, A. (2023). From a learning opportunity to a conscious multidimensional change: a metasynthesis of transcultural learning experiences among nursing students. *BMC Nursing*, 22, 1–15. <https://doi.org/10.35316/oksitosin.v9i1.1651>
- Rabiatunnisa, Indriani, & Mujahadatuljannah. (2023). Cultural Factors with Mother ' s Care in Pregnancy : Scoping Review. *Jurnal Surya Medika / JSM*, 9(3).
- Salsabila, Faizah, Z., & Prasetyo, B. (2022). Social Cultural Factors Affecting the Health Of Mother and Child (Ethnographic Study) Kesehatan Kabupaten Bandung Barat , yaitu , Meningkatnya kemampuan dan agama yang ada dalam kebudayaan termasuk memanfaatkan pelayanan. *Oksitosin: Jurnal Ilmiah Kebidanan*, 9(1), 67–79.
- Truong, M., Paradies, Y., & Priest, N. (2014). Interventions to improve cultural competency in healthcare : a systematic review of reviews. *BMC Health Services Research*, 14(99). <https://doi.org/https://doi.org/10.1186/1472-6963-14-99>
- Ulutaşdemir, N. (2023). *Transcultural Nursing Care Models*. LibreTexts. [https://med.libretexts.org/Bookshelves/Nursing/Nursing_\(Ulutasdemir\)/04%3A_Transcultural_Nursing/4.08%3A_Transcultural_Nursing_Care_Models](https://med.libretexts.org/Bookshelves/Nursing/Nursing_(Ulutasdemir)/04%3A_Transcultural_Nursing/4.08%3A_Transcultural_Nursing_Care_Models)
- Ummah, K., Badrus, A. R., Khairoh, M., Amalia, Y., Kwarta, C. P., & Kusumawardani, L. A. (2025). Enhancing Postpartum Maternal Health through Educational Interventions and Non-Invasive Biomedical Immunology-Based Monitoring in Pagesangan , Kebonsari , Surabaya. *Journal of Community Engagement in Health*, 8(1), 38–44. <https://doi.org/https://doi.org/10.30994/jceh.v8i1.701>
- Wulandari, R. A., Asmaningrum, N., & Ardiana, A. (2022). Transcultural Communication Strategies in Nursing with Multicultural Clients in Hospital Settings : A Systematic Literature Review. *Jurnal Pendidikan Keperawatan Indonesia*, 8(2), 123–138. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.17509/jpki.v9i1.55744>
- Yusnaini, Karo, D. A. B., Ayuni, D. Q., & Elvira, M. (2024). Hubungan Cultural Competency Tenaga Kesehatan dalam Layanan Homecare dengan Cultural Safety pada Masyarakat yang Berbeda Suku. *Journal of Telenursing (JOTING)*, 6(1), 130–137. <https://doi.org/https://doi.org/10.31539/joting.v6i1.8604> HUBUNGAN

BAB II

KEPERCAYAAN DAN PRAKTIK TRADISIONAL DALAM KEHAMILAN DAN PERSALINAN

A. Pendahuluan

Kehamilan dan persalinan merupakan peristiwa fisiologis yang sangat penting dalam siklus kehidupan perempuan, namun dalam konteks masyarakat, kedua peristiwa tersebut tidak hanya dipahami sebagai proses biologis semata. Kehamilan dan persalinan juga memiliki dimensi sosial, budaya, spiritual, dan psikologis yang kuat. Di berbagai komunitas, terutama masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai tradisional, pengalaman kehamilan dan persalinan sering kali diwarnai oleh kepercayaan, norma adat, serta praktik-praktik yang diwariskan secara turun-temurun. Kepercayaan dan praktik tersebut menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat, memengaruhi cara perempuan menjalani masa kehamilan, mempersiapkan persalinan, serta mengambil keputusan terkait kesehatan maternal.

Dalam perspektif antropologi kesehatan, budaya memiliki peran yang signifikan dalam membentuk persepsi individu terhadap konsep sehat, sakit, risiko, dan upaya perawatan. Pada masa kehamilan, berbagai keyakinan tradisional dapat memengaruhi perilaku ibu, mulai dari pola makan, aktivitas fisik, penggunaan ramuan herbal, hingga pemilihan penolong persalinan. Sebagian praktik tradisional berkembang berdasarkan pengalaman empiris masyarakat dan memiliki nilai positif, seperti memberikan dukungan emosional, rasa aman, serta memperkuat hubungan sosial antaranggota keluarga. Namun demikian, tidak sedikit pula praktik yang berpotensi menimbulkan risiko bagi kesehatan ibu dan janin apabila tidak sesuai dengan prinsip keselamatan medis.

Di Indonesia, keragaman budaya yang sangat luas menyebabkan variasi praktik tradisional dalam kehamilan dan persalinan juga sangat beragam. Setiap daerah memiliki nilai, simbol, ritual, dan bentuk perawatan khas yang mencerminkan identitas budaya lokal. Misalnya, terdapat masyarakat yang menerapkan pantangan makanan tertentu selama kehamilan, ritual perlindungan terhadap gangguan spiritual, penggunaan jamu atau ramuan tradisional, serta kepercayaan terhadap peran dukun beranak atau mama biang sebagai tokoh penting dalam proses persalinan. Praktik-praktik tersebut sering kali tetap bertahan meskipun akses terhadap fasilitas kesehatan modern semakin meningkat.

Keberadaan kepercayaan tradisional dalam pelayanan kesehatan maternal menuntut tenaga kesehatan, khususnya bidan, untuk memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai aspek sosial budaya masyarakat. Bidan tidak hanya dituntut menguasai kompetensi klinis, tetapi juga perlu memiliki sensitivitas budaya (*cultural sensitivity*) dalam memberikan asuhan. Pendekatan yang mengabaikan nilai budaya masyarakat dapat menimbulkan resistensi, rendahnya kepatuhan terhadap anjuran kesehatan, bahkan keterlambatan dalam mencari pertolongan medis. Sebaliknya, pendekatan yang menghargai budaya lokal dan mengintegrasikan praktik tradisional yang aman dengan pelayanan berbasis bukti (*evidence-based practice*) dapat meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap layanan kesehatan.

Pembahasan mengenai kepercayaan dan praktik tradisional dalam kehamilan dan persalinan menjadi sangat penting, terutama dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan bayi. Pemahaman yang mendalam terhadap konteks budaya memungkinkan tenaga kesehatan untuk mengidentifikasi praktik yang mendukung kesehatan serta mengenali praktik yang berisiko. Dengan demikian, pengembangan model pelayanan kebidanan yang sensitif budaya menjadi salah satu strategi penting dalam menurunkan morbiditas dan mortalitas maternal serta neonatal.

B. Kepercayaan Tradisional pada Masa Kehamilan

1. Konsep Kepercayaan Tradisional pada Masa Kehamilan

Kepercayaan tradisional pada masa kehamilan merupakan seperangkat nilai, norma, keyakinan, dan praktik yang hidup dalam masyarakat serta diwariskan secara turun-temurun sebagai pedoman dalam menjaga keselamatan ibu dan janin. Dalam konteks kesehatan maternal, kepercayaan ini memengaruhi cara ibu memahami kehamilan, mengenali tanda bahaya, menentukan pola makan, serta memilih bentuk perawatan selama masa gestasi. Kajian sistematis oleh Cukarso dan Herbawani (2020) menunjukkan bahwa budaya masih menjadi determinan utama perilaku ibu hamil di berbagai komunitas di Indonesia, khususnya pada masyarakat yang masih memegang kuat nilai tradisional.

Secara konseptual, kepercayaan tradisional tidak selalu memiliki dampak negatif. Sebagian praktik justru memberikan rasa aman, dukungan emosional, dan stabilitas psikologis bagi ibu hamil. Namun demikian, praktik yang tidak sesuai dengan prinsip *evidence-based maternal care* dapat meningkatkan risiko kesehatan bagi ibu dan janin, terutama apabila menyebabkan keterlambatan dalam mencari pelayanan kesehatan formal (Withers et al., 2018).

2. Asal-usul Nilai Budaya dan Warisan Antargenerasi

Nilai budaya dalam kehamilan umumnya berasal dari pengalaman kolektif masyarakat yang diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Pengetahuan tersebut biasanya disampaikan oleh ibu, nenek, perempuan senior dalam keluarga, maupun tokoh adat yang dianggap memiliki pengalaman lebih banyak dalam menghadapi kehamilan dan persalinan. Agus, Horiuchi, dan Porter (2012) menjelaskan bahwa perempuan di pedesaan Indonesia cenderung mengikuti nasihat keluarga dan tradisi lokal karena dianggap sebagai bentuk perlindungan terhadap ibu dan janin.

3. Pengaruh Keluarga, Tokoh Adat, dan Dukun Beranak/Mama Biang

Keluarga memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam pengambilan keputusan terkait kehamilan, terutama ibu kandung, ibu mertua, dan suami. Dalam banyak komunitas, keluarga besar sering menjadi sumber utama nasihat dan penentu keputusan terkait perawatan kehamilan. Selain keluarga, tokoh adat dan dukun beranak atau *mama biang* memiliki posisi penting sebagai figur yang dipercaya masyarakat dalam memberikan pendampingan dan nasihat tradisional (Aryastami & Mubasyiroh, 2021).

Peran *mama biang* tidak hanya sebagai penolong tradisional, tetapi juga sebagai penjaga nilai budaya yang diwariskan dalam komunitas. Dalam beberapa masyarakat, keberadaan mereka masih sangat dihormati karena dianggap memiliki pengalaman empiris dan kedekatan emosional dengan ibu hamil.

4. Praktik Tradisional Selama Kehamilan

Praktik tradisional selama kehamilan merupakan bentuk konkret dari implementasi kepercayaan budaya yang berkembang dalam masyarakat. Praktik ini dapat berupa pantangan makanan, ritual perlindungan, maupun perawatan fisik tradisional yang dilakukan untuk menjaga kesehatan ibu dan janin.

a. Pantangan Makanan

Pantangan makanan merupakan salah satu praktik budaya yang paling sering ditemukan pada ibu hamil. Larangan ini biasanya didasarkan pada keyakinan bahwa jenis makanan tertentu dapat memengaruhi pertumbuhan janin atau mempersulit proses persalinan. Fenomena ini banyak ditemukan pada berbagai etnis di Indonesia dan Asia (Withers et al., 2018).

b. Larangan Konsumsi Makanan Tertentu

Beberapa jenis makanan yang sering dianggap tabu selama kehamilan antara lain:

- 1) Nanas
- 2) Durian
- 3) Udang dan makanan laut tertentu

4) Makanan pedas

5) Makanan yang dianggap "lengket"

Masyarakat meyakini bahwa makanan tersebut dapat menyebabkan keguguran, bayi terlalu besar, atau persalinan sulit. Pada masyarakat Madura, pantangan makanan ditemukan cukup kuat dan berpengaruh terhadap perilaku ibu hamil (Rachmayanti et al., 2023).

c. Kepercayaan tentang Makanan "Panas" dan "Dingin"

Konsep makanan "panas" dan "dingin" merupakan kepercayaan tradisional yang banyak dijumpai dalam budaya Asia. Makanan seperti durian, nanas, dan rempah tertentu sering dianggap sebagai makanan panas yang berpotensi mengganggu kehamilan, sedangkan buah-buahan tertentu dianggap bersifat dingin dan lebih aman dikonsumsi (Withers et al., 2018).

d. Dampak terhadap Status Gizi Ibu

Pantangan makanan yang terlalu ketat dapat berdampak pada status gizi ibu, terutama jika membatasi asupan protein, zat besi, asam folat, dan mikronutrien penting lainnya. Pembatasan ini berisiko menyebabkan anemia, kekurangan energi kronis, serta gangguan pertumbuhan intrauterin pada janin (Aryastami & Mubasyiroh, 2021).

e. Ritual Perlindungan Kehamilan

Ritual perlindungan selama kehamilan merupakan bentuk praktik budaya yang berorientasi pada keselamatan ibu dan janin.

Penggunaan Doa, Mantra, Jimat, atau Benda Simbolik

Beberapa komunitas menggunakan:

1) Doa khusus

2) Mantra tradisional

3) Jimat

4) Benang pelindung

5) Benda simbolik tertentu

Praktik ini diyakini dapat memberikan perlindungan dari gangguan roh jahat atau nasib buruk. Praktik serupa juga ditemukan dalam berbagai budaya di Asia (Withers et al., 2018).

f. Upacara Adat untuk Keselamatan Ibu dan Janin

Ritual seperti *selamatan tujuh bulanan* atau upacara adat kehamilan memiliki fungsi spiritual dan sosial. Selain memohon keselamatan, ritual ini juga memperkuat dukungan keluarga terhadap ibu hamil (Cukarso & Herbawani, 2020).

Dari aspek psikologis, ritual tradisional dapat membantu menurunkan kecemasan ibu hamil dan meningkatkan kesiapan mental menghadapi

persalinan. Rasa tenang yang diperoleh melalui ritual budaya dapat menjadi bentuk dukungan emosional yang penting selama masa kehamilan.

5. Perawatan Fisik Tradisional

a. Pijat Ibu Hamil

Pijat tradisional pada ibu hamil dilakukan untuk mengurangi nyeri punggung, meningkatkan kenyamanan, dan membantu posisi janin. Meski demikian, praktik ini harus dilakukan secara hati-hati karena tekanan yang tidak tepat dapat berisiko bagi kehamilan (Withers et al., 2018).

b. Ramuan/Herbal Tradisional

Penggunaan herbal tradisional masih sering dilakukan untuk mengurangi mual, menjaga stamina, dan mempersiapkan persalinan. Namun, keamanan herbal perlu dipertimbangkan secara ilmiah karena tidak semua bahan memiliki bukti keamanan yang memadai bagi ibu hamil.

c. Praktik Pembatasan atau Anjuran Aktivitas

Beberapa budaya melarang ibu hamil keluar malam, duduk di depan pintu, atau mengangkat beban berat. Sebaliknya, terdapat budaya yang menganjurkan aktivitas ringan seperti berjalan kaki agar persalinan lebih mudah (Agus et al., 2012)

C. Kepercayaan dan Praktik Tradisional Saat Persalinan

Persalinan merupakan fase yang sangat sarat dengan makna budaya, spiritual, dan sosial dalam kehidupan perempuan. Pada banyak komunitas, proses melahirkan tidak hanya dipandang sebagai peristiwa biologis, tetapi juga sebagai peristiwa adat yang melibatkan keluarga, tokoh masyarakat, dan penolong persalinan tradisional. Kepercayaan dan praktik yang berkembang saat persalinan sangat memengaruhi keputusan ibu dan keluarga, mulai dari pemilihan tempat persalinan hingga penggunaan ritual dan ramuan tradisional untuk memperlancar proses kelahiran. Di Indonesia, praktik tradisional masih memiliki pengaruh signifikan terhadap pemanfaatan layanan kesehatan maternal, terutama di daerah yang akses fasilitas kesehatannya terbatas

Sebagai bagian dari konteks budaya maternal, praktik saat persalinan perlu dipahami secara komprehensif agar tenaga kesehatan, khususnya bidan, mampu memberikan pelayanan yang sensitif budaya tanpa mengabaikan aspek keselamatan ibu dan bayi.

1. Pemilihan Tempat Persalinan

Pemilihan tempat persalinan sering kali dipengaruhi oleh kepercayaan keluarga dan budaya lokal. Sebagian masyarakat masih memilih melahirkan di rumah karena dianggap lebih nyaman, lebih privat, dan memungkinkan

keterlibatan keluarga besar dalam proses persalinan. Selain itu, rumah sering dipandang sebagai tempat yang lebih aman secara spiritual dibandingkan fasilitas kesehatan formal. Aryastami dan Mubasyiroh (2021) melaporkan bahwa preferensi terhadap persalinan di rumah masih cukup tinggi pada komunitas dengan pengaruh budaya tradisional yang kuat

Beberapa alasan budaya dalam pemilihan tempat persalinan meliputi:

- a. Kedekatan dengan keluarga
- b. Kenyamanan psikologis ibu
- c. Kepercayaan terhadap penolong tradisional
- d. Pertimbangan adat dan ritual persalinan
- e. Kekhawatiran terhadap alat medis di fasilitas kesehatan

Pada beberapa masyarakat, persalinan di rumah juga memungkinkan pelaksanaan ritual adat yang sulit dilakukan di rumah sakit atau puskesmas.

2. Posisi Melahirkan Berdasarkan Adat

Posisi melahirkan merupakan salah satu praktik yang sangat dipengaruhi oleh adat dan pengalaman tradisional. Sebagian masyarakat lebih memilih posisi jongkok, duduk, atau setengah duduk karena diyakini mempermudah pengeluaran bayi dan mempercepat proses persalinan. Posisi ini sering diwariskan berdasarkan pengalaman perempuan yang lebih tua atau rekomendasi *mama biang*.

Beberapa posisi yang umum ditemukan antara lain:

- a. Jongkok, untuk membantu dorongan gravitasi
- b. Setengah duduk, agar ibu lebih nyaman
- c. Berbaring miring, untuk mengurangi tekanan
- d. Duduk dengan penopang keluarga, sebagai bentuk dukungan emosional

3. Peran Dukun Beranak / Mama Biang

Dukun beranak atau *mama biang* memiliki peran sentral dalam budaya persalinan tradisional. Figur ini biasanya dipercaya karena pengalaman, kedekatan emosional dengan keluarga, serta legitimasi budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Banyak keluarga merasa lebih nyaman menggunakan jasa *mama biang* karena dianggap lebih sabar, lebih memahami kondisi ibu, dan lebih selaras dengan tradisi masyarakat.

Peran *mama biang* biasanya meliputi:

- a. Mendampingi ibu selama proses persalinan
- b. Memberikan dukungan emosional dan spiritual
- c. Memandu teknik mengejan secara tradisional
- d. Melakukan pijat atau sentuhan tertentu
- e. Membantu perawatan awal ibu dan bayi

Namun demikian, praktik persalinan yang hanya ditolong oleh dukun beranak tanpa tenaga kesehatan terlatih dapat meningkatkan risiko keterlambatan penanganan komplikasi obstetri, seperti perdarahan postpartum atau partus lama (Aryastami & Mubasyiroh, 2021).

4. Ritual Menjelang dan Sesudah Bayi Lahir

Ritual menjelang persalinan umumnya dilakukan sebagai bentuk doa dan harapan agar proses melahirkan berjalan lancar. Ritual ini dapat berupa pembacaan doa, pemberian air yang telah didoakan, penggunaan jimat, atau upacara adat kecil yang melibatkan keluarga. Sesudah bayi lahir, beberapa masyarakat juga melakukan ritual tertentu seperti:

- a. Pemotongan tali pusat dengan alat tradisional
- b. Penyimpanan atau penguburan plasenta secara adat
- c. Pemberian doa pada bayi baru lahir
- d. Pembatasan kunjungan orang luar
- e. Isolasi ibu selama masa awal nifas
- f. Praktik seperti penguburan plasenta memiliki makna simbolik yang kuat, yaitu sebagai bentuk penghormatan terhadap bagian tubuh bayi yang dianggap memiliki hubungan spiritual dengan kehidupannya kelak

5. Penggunaan Ramuan untuk Mempercepat Persalinan

Pada beberapa budaya, ibu yang akan melahirkan diberikan ramuan herbal atau minuman tradisional yang diyakini dapat mempercepat pembukaan dan memperlancar kontraksi. Ramuan ini biasanya terbuat dari bahan lokal seperti jahe, kunyit, daun tertentu, atau campuran herbal keluarga.

Secara budaya, penggunaan ramuan dipandang sebagai bentuk ikhtiar tradisional untuk membantu proses kelahiran. Namun, dari perspektif medis, penggunaan herbal harus diperhatikan secara hati-hati karena tidak semua bahan aman untuk ibu bersalin. Beberapa ramuan bahkan dapat memicu kontraksi berlebihan atau meningkatkan risiko perdarahan apabila digunakan tanpa takaran yang jelas (Withers et al., 2018).

D. Nilai Positif dan Risiko Kesehatan

Kepercayaan dan praktik tradisional dalam kehamilan serta persalinan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem budaya masyarakat. Praktik tersebut tidak selalu harus dipandang sebagai hambatan dalam pelayanan kesehatan, karena pada kenyataannya beberapa di antaranya memiliki nilai positif yang mendukung kesejahteraan ibu. Namun demikian, sebagian praktik juga dapat menimbulkan risiko kesehatan apabila bertentangan dengan prinsip keselamatan

maternal dan neonatal. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang seimbang antara nilai budaya dan aspek klinis dalam praktik kebidanan.

Subbab ini membahas dua sisi utama dari praktik tradisional, yaitu nilai positif yang mendukung ibu dan keluarga, serta risiko kesehatan yang perlu diantisipasi oleh tenaga kesehatan.

1. Nilai Positif Praktik Tradisional

Praktik tradisional dalam kehamilan dan persalinan pada banyak komunitas memiliki fungsi sosial, psikologis, dan spiritual yang sangat penting. Nilai positif ini sering kali menjadi alasan mengapa tradisi tetap bertahan dari generasi ke generasi.

a. Dukungan Emosional dan Sosial

Salah satu nilai utama praktik tradisional adalah adanya dukungan emosional yang kuat dari keluarga dan komunitas. Ritual kehamilan, pendampingan oleh ibu atau mertua, serta keterlibatan *mama biang* dapat meningkatkan rasa aman dan kenyamanan ibu. Dukungan keluarga terbukti berperan penting dalam meningkatkan kesiapan mental ibu selama kehamilan dan persalinan. Kehadiran keluarga dalam proses persalinan juga memberikan rasa percaya diri dan menurunkan kecemasan ibu, terutama pada primigravida.

b. Penguatan Nilai Spiritual dan Psikologis

Doa, ritual adat, dan penggunaan simbol-simbol budaya sering memberikan ketenangan batin bagi ibu. Secara psikologis, kondisi ini dapat membantu mengurangi stres dan ketakutan terhadap proses persalinan. Ketenteraman emosional selama persalinan diketahui berkontribusi terhadap kelancaran proses fisiologis persalinan.

Dengan demikian, praktik budaya tertentu dapat berfungsi sebagai bentuk *coping mechanism* yang memperkuat kesiapan psikologis ibu.

c. Penguatan Identitas Budaya dan Solidaritas Keluarga

Tradisi persalinan juga berfungsi memperkuat identitas budaya masyarakat. Melalui ritual dan praktik adat, keluarga merasa terhubung dengan nilai leluhur dan warisan antargenerasi. Hal ini memperkuat solidaritas sosial dan kohesi keluarga dalam mendampingi ibu.

2. Risiko Kesehatan dari Praktik Tradisional

Di samping nilai positif, beberapa praktik tradisional dapat meningkatkan risiko kesehatan ibu dan bayi apabila dilakukan tanpa pertimbangan medis yang tepat.

a. Keterlambatan Rujukan ke Fasilitas Kesehatan

Salah satu risiko utama adalah keterlambatan dalam mengambil keputusan untuk dirujuk ke fasilitas kesehatan saat terjadi komplikasi. Kepercayaan yang

terlalu besar terhadap dukun beranak atau persalinan di rumah dapat menyebabkan keterlambatan penanganan kasus gawat darurat obstetri, seperti perdarahan postpartum, preeklamsia, dan partus lama. Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa praktik tradisional secara signifikan menurunkan peluang persalinan di fasilitas kesehatan.

Kondisi ini berkaitan dengan konsep *three delays*, terutama keterlambatan pengambilan keputusan oleh keluarga.

b. Risiko Infeksi dan Komplikasi Persalinan

Beberapa praktik tradisional, seperti pemotongan tali pusat menggunakan alat yang tidak steril atau penggunaan bahan tertentu pada luka perineum, dapat meningkatkan risiko infeksi pada ibu maupun bayi baru lahir. Praktik ini masih ditemukan pada beberapa komunitas yang sangat kuat memegang tradisi persalinan rumah.

Selain itu, manipulasi manual oleh penolong tradisional yang tidak terlatih juga dapat meningkatkan risiko trauma jalan lahir dan retensio plasenta.

c. Penggunaan Ramuan yang Tidak Terstandar

Penggunaan herbal atau ramuan untuk mempercepat kontraksi perlu mendapat perhatian khusus. Dosis yang tidak jelas serta kandungan bahan aktif yang belum teruji dapat memicu hiperstimulasi uterus, fetal distress, bahkan perdarahan. Oleh karena itu, praktik ini memerlukan pendekatan edukatif dari bidan agar masyarakat memahami batas keamanan penggunaannya.

d. Dampak terhadap Status Gizi dan Pemulihan Ibu

Pantangan makanan pascapersalinan yang terlalu ketat dapat mengganggu proses pemulihan ibu dan produksi ASI. Pembatasan protein, cairan, atau makanan bergizi tertentu dapat memperlambat penyembuhan luka serta meningkatkan risiko anemia postpartum.

E. Implikasi bagi Praktik Kebidanan

Pemahaman terhadap nilai positif dan risiko praktik tradisional sangat penting dalam pelayanan kebidanan berbasis budaya. Bidan perlu mampu mengidentifikasi praktik yang masih aman untuk dipertahankan serta memberikan edukasi terhadap praktik yang berpotensi membahayakan ibu dan bayi.

Pendekatan yang direkomendasikan adalah integrasi budaya dan evidence-based care, yaitu menghargai tradisi lokal tanpa mengabaikan standar keselamatan maternal dan neonatal.

F. Perspektif Kebidanan dan Integrasi Pelayanan Sensitif Budaya

Dalam konteks pelayanan kesehatan maternal, bidan memiliki peran strategis sebagai tenaga kesehatan terdepan yang berinteraksi langsung dengan ibu, keluarga, dan komunitas. Oleh karena itu, pelayanan kebidanan tidak hanya menekankan aspek klinis dan teknis, tetapi juga perlu memperhatikan nilai budaya, keyakinan, dan praktik tradisional yang hidup di masyarakat. Pendekatan ini dikenal sebagai pelayanan sensitif budaya (*culturally sensitive care*), yaitu pelayanan yang menghargai nilai, kepercayaan, dan kebiasaan pasien tanpa mengabaikan prinsip keselamatan ibu dan bayi.

Pelayanan sensitif budaya menjadi sangat penting pada masyarakat yang masih kuat memegang tradisi, termasuk dalam praktik kehamilan, persalinan, dan masa nifas. Pendekatan yang mengabaikan budaya lokal berpotensi menimbulkan resistensi, rendahnya kepatuhan terhadap anjuran kesehatan, bahkan keterlambatan dalam mencari pertolongan medis. Sebaliknya, pelayanan yang menghormati budaya akan meningkatkan kepercayaan ibu terhadap bidan dan fasilitas kesehatan.

1. Peran Bidan dalam Memahami Nilai Budaya Masyarakat

Bidan perlu memiliki kompetensi budaya (*cultural competence*) agar mampu memahami makna praktik tradisional yang dijalankan oleh ibu dan keluarga. Kompetensi ini mencakup kemampuan untuk:

- a. Memahami kepercayaan lokal terkait kehamilan dan persalinan
- b. Mengidentifikasi praktik yang aman dan yang berisiko
- c. Menghargai nilai spiritual serta simbolik masyarakat
- d. Membangun komunikasi yang empatik dan tidak menghakimi
- e. Melakukan edukasi kesehatan berbasis budaya

Leininger's transcultural nursing theory menekankan bahwa asuhan yang efektif harus sesuai dengan nilai budaya pasien agar dapat diterima dan dijalankan secara optimal. Dalam konteks kebidanan, hal ini berarti bidan perlu memandang budaya bukan sebagai hambatan, tetapi sebagai konteks penting dalam pemberian asuhan. Sebagai contoh, ketika ibu hamil memegang pantangan makanan tertentu, bidan tidak langsung menolak praktik tersebut, tetapi perlu mengeksplorasi makna budaya di baliknya dan memberikan alternatif nutrisi yang tetap sesuai dengan kebutuhan ibu.

2. Komunikasi Terapeutik Berbasis Budaya

Komunikasi terapeutik merupakan inti dari pelayanan kebidanan sensitif budaya. Bidan harus mampu menggunakan bahasa yang mudah dipahami, menghormati istilah lokal, serta melibatkan keluarga dalam proses konseling.

Beberapa prinsip komunikasi berbasis budaya meliputi:

- a. Mendengarkan keyakinan ibu tanpa menghakimi

- b. Menggunakan pendekatan persuasif dan edukatif
- c. Menghormati bahasa dan istilah lokal
- d. Melibatkan suami, ibu, atau mertua dalam pengambilan keputusan
- e. Mengaitkan pesan kesehatan dengan nilai budaya yang diterima masyarakat

Penelitian menunjukkan bahwa pendekatan komunikasi yang menghargai budaya meningkatkan penerimaan terhadap persalinan di fasilitas kesehatan dan kunjungan antenatal secara rutin.

Dengan demikian, komunikasi yang sensitif budaya menjadi strategi penting dalam mengurangi *first delay* pada pelayanan maternal.

3. Integrasi Praktik Tradisional yang Aman dengan Evidence-Based Care

Tidak semua praktik tradisional perlu dihilangkan. Beberapa praktik dapat diintegrasikan dengan pelayanan modern selama tidak membahayakan ibu dan bayi. Prinsip integrasi ini menekankan kolaborasi antara budaya lokal dan praktik berbasis bukti (*evidence-based practice*).

Contoh praktik yang dapat diintegrasikan antara lain:

- a. Doa atau ritual spiritual untuk menenangkan ibu
- b. Pendampingan keluarga selama persalinan
- c. Posisi melahirkan yang nyaman dan aman
- d. Penggunaan pijat relaksasi yang sesuai standar
- e. Konsumsi herbal yang telah dievaluasi keamanannya

Sebaliknya, praktik yang berpotensi berisiko seperti penggunaan alat tidak steril, ramuan tidak terstandar, atau keterlambatan rujukan perlu mendapatkan edukasi khusus.

4. Kolaborasi dengan Tokoh Adat dan Dukun Beranak

Pada masyarakat tertentu, tokoh adat dan *mama biang* masih memiliki pengaruh yang sangat besar dalam keputusan keluarga. Oleh karena itu, pendekatan kolaboratif perlu dikembangkan agar tokoh budaya dapat menjadi mitra dalam promosi kesehatan maternal.

Kolaborasi ini dapat dilakukan melalui:

- a. Edukasi bersama tokoh adat
- b. Pelibatan *mama biang* dalam deteksi dini tanda bahaya
- c. Sistem rujukan kolaboratif ke bidan atau puskesmas
- d. Penguatan peran tokoh masyarakat sebagai agen perubahan

Pendekatan ini telah terbukti meningkatkan akses ibu ke fasilitas kesehatan tanpa menimbulkan konflik budaya di masyarakat.

5. Implikasi bagi Pendidikan dan Praktik Kebidanan

Perspektif sensitif budaya perlu menjadi bagian integral dalam pendidikan kebidanan. Mahasiswa kebidanan perlu dibekali kemampuan untuk melakukan

pengkajian budaya, komunikasi lintas budaya, serta pengambilan keputusan klinis yang menghargai nilai masyarakat.

G. Simpulan

Kepercayaan dan praktik tradisional dalam kehamilan dan persalinan merupakan bagian integral dari sistem nilai, norma, dan budaya yang hidup dalam masyarakat. Praktik-praktik tersebut tidak hanya merefleksikan warisan antargenerasi, tetapi juga menunjukkan bagaimana masyarakat memaknai kehamilan dan persalinan sebagai peristiwa biologis, sosial, spiritual, dan budaya. Berbagai bentuk kepercayaan, seperti pantangan makanan, ritual perlindungan, penggunaan ramuan tradisional, pemilihan tempat persalinan, serta keterlibatan *dukun beranak* atau *mama biang*, masih memiliki pengaruh yang kuat terhadap perilaku ibu dan keluarga dalam mengambil keputusan terkait kesehatan maternal.

Referensi

- Agus, Y., Horiuchi, S., & Porter, S. E. (2012). Rural Indonesia women's traditional beliefs about antenatal care. *BMC Research Notes*, 5, 589.
- Anita, N. (2024). Midwifery practices in promoting maternal and neonatal health. *Advances in Healthcare Research*, 2(1), 1–12.
- Aprianti, N. A., et al. (2024). Herbal use and cultural influences in midwifery-led care: A scoping review. *Science Midwifery*, 12(3).
- Aryastami, N. K., & Mubasyiroh, R. (2021). Traditional practices influencing the use of maternal health care services in Indonesia. *PLOS ONE*, 16(9), e0257032.
- Aryastami, N. K., & Mubasyiroh, R. (2021). Traditional practices influencing the use of maternal health care services in Indonesia. *PLOS ONE*, 16(9), e0257032.
- Busro, B., Hilmi, F., & Qodim, H. (2024). Harmonizing traditional and modern maternal healthcare practices in Cirebon, Indonesia. *Journal of Education Culture and Society*, 15(1), 567–584.
- Cukarso, S. N. A., & Herbawani, C. K. (2020). Traditional beliefs and practices among pregnant women in Javanese communities. *Journal of Public Health Research and Community Health Development*, 4(1), 71–80.
- Lestari, L., & Ramadhaniyati, R. (2019). Malay cultural practice and childbirth with traditional birth attendants. *Belitung Nursing Journal*, 5(1).

- Rachmayanti, R. D., et al. (2023). Culture, traditional beliefs and practices during pregnancy among the Madurese tribe in Indonesia. *British Journal of Midwifery*, 31(3), 148–156.
- Sulistyorini, D., et al. (2025). Exploring cultural factors contributing maternal mortality among pregnant women in Central Java. *Frontiers in Global Women's Health*.
- Withers, M., Kharazmi, N., & Lim, E. (2018). Traditional beliefs and practices in pregnancy, childbirth and postpartum: A review of the evidence from Asian countries. *Midwifery*, 56, 158–170. <https://doi.org/10.1016/j.midw.2017.10.019>

BAB III

PENGARUH BUDAYA TERHADAP KEPUTUSAN PERSALINAN

A. Pendahuluan

Indonesia adalah Negara dengan keanekaragaman budaya yang tinggi, yang sangat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk aspek kesehatan individu maupun keluarga, termasuk kesehatan maternal neonatal. Dalam konteks kesehatan maternal, keputusan terkait tempat persalinan hingga penolong persalinan tidak hanya ditentukan oleh faktor medis, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh nilai, kepercayaan, dan praktik budaya yang dianut oleh masyarakat.

Budaya memegang peran fundamental dalam membentuk cara pandang, interpretasi, dan persepsi masyarakat terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk kehamilan dan persalinan. Budaya menyusun kerangka nilai, norma, dan keyakinan bersama dalam menentukan apa yang dianggap normal, benar, salah, atau penting. Pada banyak komunitas di Indonesia, persalinan tidak semata-mata dipandang sebagai proses biologis, tetapi juga sebagai peristiwa sosial dan spiritual yang sarat makna. Hal ini menyebabkan adanya variasi dalam pengambilan keputusan terkait tempat persalinan, penolong persalinan, serta ritual adat yang dilakukan selama proses persalinan. Dalam beberapa kajian budaya masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa faktor sosial budaya masih menjadi salah satu hambatan dalam upaya peningkatan persalinan aman di Indonesia. Masyarakat memiliki konsep tersendiri mengenai persalinan yang dianggap aman, yang tidak selalu sejalan dengan standar medis modern, karena budaya merupakan determinan sosial yang sangat kuat dalam membentuk perilaku kesehatan, termasuk dalam keputusan persalinan. Dalam konteks Indonesia, budaya tidak hanya mempengaruhi preferensi individu, tetapi juga membentuk norma kolektif yang menjadi acuan dalam bertindak dan berperilaku.

Kajian meta etnografi menunjukkan bahwa masyarakat memiliki definisi sendiri tentang "persalinan aman", yang sering kali berbeda dengan perspektif medis. Bagi masyarakat, persalinan dianggap aman apabila dilakukan sesuai dengan nilai budaya, memberikan kenyamanan, dan tidak melanggar norma sosial setempat. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan persalinan tidak bersifat rasional-medis semata,

tetapi merupakan hasil konstruksi sosial budaya yang kompleks. (Lestari, W., & Agustina, Z. A. (2018)).

B. Konsep Budaya Dalam Kesehatan maternal

Kesehatan ibu hamil merupakan salah satu indikator status kesehatan masyarakat. Masalah kehamilan, persalinan, nifas hingga bayi baru lahir berkaitan erat dengan unsur budaya di masyarakat. Bila kita lihat dari bentangan wilayah, hampir semua budaya dari Sabang hingga Merauke memiliki tradisi dalam proses kehamilan, persalinan dan kelahiran bayi. Di Indonesia, budaya dapat diartikan sebagai sistem nilai, kepercayaan, norma, dan praktik yang dipelajari dan diwariskan turun temurun baik melalui lisan/tuturan maupun tulisan dalam suatu kelompok masyarakat, sehingga sangat mempengaruhi perilaku individu, keluarga dan masyarakat dalam bertindak termasuk dalam memilih layanan kesehatan. Budaya juga membentuk apa yang disebut sebagai *health belief*, yaitu keyakinan individu terhadap kesehatan dan penyakit. Misalnya, sebagian masyarakat percaya bahwa persalinan adalah proses alami yang tidak memerlukan intervensi medis, sehingga lebih memilih melahirkan di rumah dengan bantuan dukun beranak.

Selain itu, budaya dapat menjadi faktor penghambat maupun pendukung dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan. Dalam beberapa kasus, budaya justru lebih dominan dibandingkan pengetahuan medis dalam menentukan perilaku kesehatan ibu.

Dalam kesehatan maternal, budaya dapat mempengaruhi:

1. Persepsi ibu terhadap kehamilan dan persalinan

Dalam kesehatan maternal, budaya masih berperan dalam membentuk persepsi ibu hamil terhadap proses kehamilan dan persalinan. Pengaruh ini sering kali mencakup kepercayaan tradisional, pantangan, dan ritual yang dapat berdampak positif maupun negatif terhadap kesehatan ibu dan bayi. Budaya mempengaruhi persepsi ibu melalui norma sosial, kepercayaan supranatural, dan praktik lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Pada sebagian masyarakat Indonesia, persepsi kematian ibu sering dihubungkan dengan faktor non-medis seperti roh jahat atau nasib, sehingga menurunkan prioritas pemeriksaan kesehatan formal. Hal ini menyebabkan ibu cenderung pasrah terhadap komplikasi selama hamil, melahirkan, atau nifas. (Aryastami, N. K., & Mubasyiroh, R. (2019)).

2. Sikap terhadap tenaga kesehatan

Sikap ibu hamil terhadap tenaga kesehatan memainkan peran penting dalam keberhasilan pelayanan kesehatan ibu dan bayi. Sikap ini selain dipengaruhi oleh faktor budaya, pengalaman sebelumnya, dan kepercayaan

pribadi, juga dapat terbina kerjasama atau bahkan hambatan dalam proses perawatan.

Sikap ibu akan positif jika tenaga kesehatan menunjukkan empati dan komunikasi yang baik, seperti menjelaskan prosedur dengan bahasa sederhana. Namun, pengalaman negatif seperti sikap kasar atau kurangnya privasi dapat menimbulkan ketakutan ataupun penolakan terhadap layanan di fasilitas pelayanan kesehatan. Apalagi di beberapa wilayah di Indonesia, kepercayaan budaya terhadap dukun tradisional sering membuat ibu ragu pada bidan atau dokter (Moeda, V. S., Zakaria, F., & Yunus, Y. (2026)).

3. Pilihan tempat dan penolong persalinan

Pilihan tempat dan penolong persalinan merupakan keputusan kritis yang mempengaruhi keselamatan ibu dan bayi dalam kesehatan maternal. Ibu hamil sering memilih tempat persalinan berdasarkan aksesibilitas, biaya, dan kepercayaan budaya, seperti rumah sendiri atau balai desa karena dianggap lebih alami dan hemat. Penolong persalinan dipengaruhi oleh faktor sosial seperti dukun tradisional yang dipercaya turun-temurun, meski berisiko tinggi akibat kurangnya sterilitas dan pengetahuan medis.

4. Praktik perawatan selama kehamilan dan persalinan

Praktik perawatan selama kehamilan dan persalinan masih berlangsung kombinasi pendekatan medis modern dan tradisional yang dipengaruhi budaya lokal. Praktik ini bertujuan menjaga kesehatan ibu dan janin, namun sering kali menimbulkan risiko jika tidak selaras dengan standar medis. Selama hamil pemeriksaan antenatal rutin sebanyak 6 kali, pengukuran berat badan, tekanan darah, dan skrining seperti diabetes gestasional. Selama persalinan, fokus pada penanganan komplikasi di fasilitas kesehatan untuk memastikan persalinan aman. Nutrisi seimbang, senam hamil, dan istirahat cukup direkomendasikan untuk mendukung perkembangan janin (Lestari, W.. (2023))

C. Persepsi dan Kepercayaan Budaya tentang Persalinan

Dalam berbagai budaya di Indonesia, persalinan sering dikaitkan dengan nilai-nilai spiritual dan kepercayaan tradisional. Banyak masyarakat meyakini bahwa keselamatan ibu dan bayi tidak hanya ditentukan oleh faktor medis, tetapi juga oleh kekuatan supranatural.

Beberapa bentuk kepercayaan yang umum ditemukan antara lain:

1. Persalinan sebagai proses alami yang tidak boleh “diganggu” oleh intervensi medis
2. Adanya pantangan makanan tertentu selama kehamilan
3. Ritual khusus menjelang atau setelah persalinan

4. Keyakinan terhadap kemampuan dukun beranak

Kepercayaan masyarakat terhadap dukun beranak sering didasarkan pada hubungan emosional dan kepercayaan yang telah terbangun lama antara masyarakat dan dukun tersebut. Praktik kesehatan ibu melahirkan pada rata-rata budaya Indonesia mencakup penggunaan ramuan herbal, pijat tradisional, dan doa-doa adat yang diyakini menjaga keseimbangan spiritual dan kesehatan fisik ibu. Meskipun demikian, terdapat keterbukaan terhadap intervensi medis modern dalam situasi tertentu, seperti dalam penanganan komplikasi persalinan. Harmoni antara praktik tradisional dan modern mencerminkan adaptasi budaya lokal tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya (Ningrum, W. M., Purnamasari, K. D., & Rohmah, S. (2024))

Di sisi lain, masih terdapat masyarakat yang berpersepsi negatif terhadap pelayanan di fasilitas kesehatan seperti:

1. Rasa malu memperlihatkan organ reproduksi

Banyak ibu, terutama remaja dan wanita usia subur, merasa malu saat pemeriksaan reproduksi karena stigma moral yang mengaitkan dengan perilaku seksual menyimpang atau kekhawatiran kerahasiaan. Persepsi negatif di kalangan remaja, membuat mereka enggan ke puskesmas. Harmonisasi layanan seperti privasi ruang dan komunikasi terapeutik dapat mengurangi hambatan ini

2. Ketakutan terhadap pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan

Rasa takut terutama jika persalinan dilakukan di fasyankes, bukan di rumah. Dampak psikologis ketakutan melahirkan adalah kecemasan berlebihan yang dapat mempengaruhi kesejahteraan mental dan emosional seorang wanita hamil. Kondisi ini dapat menyebabkan stres, kegelisahan, depresi, dan bahkan gangguan makan. Dengan memahami akar penyebab ketakutan melahirkan dan cara mengatasinya, para bidan dapat membantu wanita hamil untuk mengelola ketakutan tersebut dan meningkatkan kualitas hidup mereka selama masa kehamilan (Lestari, S., Hermayanti, Y., & Maryati, I. (2023))

3. Anggapan bahwa petugas kesehatan kurang ramah

Alasan lain masyarakat masih mempercayakan persalinan mereka kepada dukun bayi karena dukun bayi merupakan seorang yang berpengaruh di masyarakat yang diyakini dan dipercaya mempunyai keterampilan dan kemampuan untuk menolong persalinan. Kepercayaan seseorang tergantung pada pengalaman dari orang itu sendiri, Sikap masyarakat terhadap persalinan yang ditolong oleh dukun bayi karena ibu hamil lebih memilih melahirkan di rumah karena dukun bayi lebih perhatian dan sabar dalam merawat ibu dan bayi. Hamid, H., Ramli, R., & Ishak, S. N. (2022).

Persepsi negatif terhadap fasilitas pelayanan kesehatan dan petugas kesehatan akan mempengaruhi keinginan masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan. Dengan rasa malu, ketakutan, dan anggapan sikap petugas yang kurang ramah, tentunya mempengaruhi jumlah kunjungan ANC. Persepsi masyarakat, terutama ibu hamil ini tentunya muncul dari norma budaya dan pengalaman pribadi, sehingga pendekatan empati dan komunikasi efektif dari tenaga kesehatan sangat penting untuk membangun kepercayaan.

D. Pengambilan Keputusan Persalinan dalam Konteks Budaya

Pengambilan keputusan persalinan dalam konteks budaya tentunya sangat dipengaruhi oleh norma lokal, kepercayaan tradisional, dan dukungan keluarga, yang dianggap mendukung kenyamanan ibu hamil, meskipun kenyataannya akan berisiko secara medis. Dalam beberapa kasus, ibu tidak memiliki otonomi penuh dalam menentukan tempat persalinan. Selain itu, tekanan sosial dari lingkungan sekitar turut berperan. Misalnya, jika mayoritas masyarakat di suatu daerah melahirkan dengan bantuan dukun, maka individu cenderung mengikuti praktik tersebut. Penelitian Andia F *2019), menunjukkan bahwa faktor budaya memiliki hubungan signifikan dengan pemilihan penolong persalinan, bahkan meningkatkan kemungkinan memilih dukun beranak dibanding tenaga kesehatan.

Pengambilan keputusan persalinan dalam konteks budaya di Indonesia sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai lokal, kepercayaan tradisional, serta struktur sosial masyarakat. Budaya berperan penting dalam menentukan siapa yang mengambil keputusan, di mana persalinan dilakukan, dan siapa yang menolong proses persalinan

Berikut adalah poin-poin penting pengambilan keputusan persalinan dalam konteks budaya (Bakoil, M. B., & Diaz, M. F. (2020)).

- 1. Peran Pengambil Keputusan:** Di banyak daerah, terutama di pedesaan, suami atau anggota keluarga tertua (seperti mertua atau orang tua) merupakan pengambil keputusan utama terkait lokasi dan penolong persalinan.
- 2. Pengaruh Tradisi dan Kepercayaan:** Kepercayaan lokal, seperti pantangan makanan tertentu, ritual adat, atau penggunaan dukun beranak, masih kuat mempengaruhi perilaku kesehatan ibu hamil. Dukun beranak seringkali dianggap memiliki ikatan emosional dan spiritual yang lebih kuat dibandingkan tenaga medis.
- 3. Dukungan Suami:** Keputusan suami untuk menerima informasi kesehatan dan mendorong istri bersalin dengan tenaga kesehatan jarang terjadi, terutama di tengah pengaruh adat istiadat yang masih kental.

- 4. Pergeseran Budaya dan Medis:** Sebagian masyarakat mulai mengadopsi praktik medis modern, namun tetap mengintegrasikannya dengan unsur budaya lokal sebagai bentuk penghormatan tradisi.
- 5. Faktor Eksternal:** Faktor seperti usia ibu, paritas, pendidikan, pendapatan, dan jarak ke fasilitas kesehatan juga mempengaruhi keputusan, namun seringkali disaring melalui nilai-nilai budaya setempat.

E. Praktik Budaya dalam Persalinan

Pada masyarakat multikultural seperti Indonesia Praktik budaya dalam pertolongan persalinan merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari pengalaman reproduksi perempuan, terutama di daerah terpencil. Setiap komunitas atau suku memiliki budaya yang membentuk nilai, kepercayaan, dan tradisi yang mempengaruhi cara pandang terhadap kehamilan dan persalinan. Banyak praktik budaya di Indonesia, memandang persalinan tidak hanya sebagai peristiwa biologis, tetapi juga sebagai peristiwa sosial dan spiritual yang sarat makna. Misalnya, keberadaan pendamping persalinan seperti ibu, suami, atau bahkan dukun beranak sering dianggap penting untuk memberikan rasa aman dan dukungan emosional. Di sisi lain, terdapat pula praktik seperti pantangan makanan, penggunaan ramuan tradisional, hingga ritual tertentu yang diyakini dapat memperlancar proses persalinan atau melindungi ibu dan bayi dari gangguan yang tidak terlihat.

Praktik budaya dalam pertolongan persalinan memiliki dua sisi, yakni sisi yang menguntungkan dan yang merugikan. Sisi yang menguntungkan yakni dukungan keluarga saat persalinan, terbukti memberikan manfaat, karena dapat mengurangi kecemasan ibu, dukungan dari keluarga dan meningkatkan pengalaman persalinan yang menyenangkan. Sedangkan negatifnya adalah praktik budaya yang berpotensi menimbulkan risiko, seperti keterlambatan mencari pertolongan medis karena kepercayaan terhadap metode tradisional atau pembatasan asupan nutrisi yang justru dapat memperburuk kondisi ibu. Oleh karena itu, tenaga kesehatan, khususnya bidan, perlu memiliki kompetensi dalam memahami dan menghargai praktik budaya tersebut, sekaligus mampu melakukan pendekatan edukatif untuk mengintegrasikan praktik yang aman dengan standar pelayanan kesehatan modern (Gabrysch, S., & Campbell, O. M. R. (2009).

Untuk dapat menerapkan praktik kebidanan profesional agar angka kematian ibu dapat ditekan, Pendekatan kebidanan transkultural menjadi sangat penting, karena menekankan pada pemberian asuhan yang sensitif terhadap budaya namun tetap mengedepankan prinsip keselamatan ibu dan bayi. Dengan memahami latar belakang budaya pasien, bidan dapat membangun komunikasi yang lebih efektif,

meningkatkan kepercayaan, serta mendorong penggunaan layanan kesehatan secara optimal. Sejalan dengan itu, World Health Organization menekankan bahwa pelayanan maternitas yang berkualitas harus bersifat hormat, responsif terhadap kebutuhan sosial budaya perempuan, dan bebas dari praktik yang merugikan.

Beberapa praktik yang umum ditemukan di berbagai daerah di Indonesia, terutama di wilayah pedesaan dan terpencil antara lain:

1. Persalinan di rumah
2. Penggunaan ramuan tradisional
3. Posisi persalinan tradisional
4. Ritual tertentu untuk keselamatan ibu dan bayi

F. Dampak Budaya terhadap Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan

Dampak budaya terhadap pemanfaatan pelayanan kesehatan merupakan isu penting dalam pelayanan kesehatan masyarakat, terutama pada pelayanan ibu dan anak. Dalam kehidupan masyarakat kita, budaya tidak hanya membentuk sikap dan pandangan hidup individu dalam memahami tentang sehat dan sakit, melainkan juga mempengaruhi pengambilan keputusan dalam menentukan kapan waktu yang tepat untuk berobat, serta di mana, dan kepada siapa seseorang mencari pertolongan. Pada kebanyakan Masyarakat desa, keputusan untuk menggunakan layanan kesehatan tidak sepenuhnya berdasarkan keinginan individual, melainkan dipengaruhi oleh norma sosial, kepercayaan keluarga, serta nilai-nilai tradisional yang diwariskan secara turun-temurun, atau kebiasaan yang selama ini berlaku dalam komunitas tersebut.

Berbagai penelitian membuktikan bahwa budaya memiliki pengaruh yang kuat terhadap perilaku pencarian pelayanan kesehatan. Nuraini (2025), menemukan bahwa variabel "local wisdom" seperti mitos, kepercayaan, dan praktik tradisional secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pemanfaatan pelayanan kesehatan ibu. Semakin kuat kepercayaan terhadap mitos, semakin rendah kecenderungan ibu untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan modern. Dalam beberapa komunitas, ibu hamil lebih memilih pengobatan tradisional seperti pijat, ramuan tradisional ataupun ritual adat dari dukun beranak dibandingkan pergi ke fasilitas kesehatan, karena dianggap lebih sesuai dengan nilai budaya dan lebih mudah diakses secara sosial. Hal ini menunjukkan bahwa budaya dapat menjadi faktor penghambat (barrier) dalam akses pelayanan kesehatan formal (Aryastami, NK, & Mubasyiroh, R. (2019)).

Selain sebagai sistem nilai, budaya juga berperan dalam struktur sosial, terutama dalam pengambilan keputusan keluarga. Dalam struktur sosial keluarga Indonesia, menunjukkan bahwa dukungan keluarga, terutama suami dan anggota

keluarga lain, memiliki pengaruh besar terhadap keputusan ibu untuk menggunakan layanan kesehatan. Dalam konteks masyarakat Asia, keluarga sering menjadi unit utama dalam menentukan akses pelayanan kesehatan, sehingga persetujuan dan dukungan keluarga menjadi faktor kunci dalam pemanfaatan pelayanan maternal (Herwansyah, et al., (2024)). Dengan demikian, budaya tidak hanya bekerja melalui kepercayaan individu, tetapi juga melalui dinamika sosial dan relasi kekuasaan dalam keluarga.

Terdapatnya ketidaksesuaian antara praktik budaya lokal dengan layanan kesehatan modern akan menjadi penyebab rendahnya pemanfaatan fasilitas Pelayanan kesehatan, apalagi jika layanan kesehatan yang bersentuhan dengan kebiasaan turun temurun yang selama ini dipraktikkan. Tinjauan literatur menunjukkan bahwa banyak komunitas tradisional menganggap bahwa prosedur medis tidak mengakomodir praktik budaya yang memiliki makna simbolik dan spiritual, karena itu mereka enggan memanfaatkan pelayanan kesehatan formal. Hal ini menegaskan pentingnya pendekatan pelayanan yang berbasis budaya (*culturally sensitive care*) dalam meningkatkan akses dan penerimaan layanan kesehatan. (Ahmad, A. D., Hanita, M., & Nurhasana, R. (2025)). Meski demikian budaya tidak selalu berdampak negatif. Dalam beberapa konteks, nilai budaya seperti solidaritas keluarga, dukungan sosial, dan pengalaman saat berinteraksi di masyarakat justru dapat meningkatkan pemanfaatan pelayanan kesehatan. Pengalaman keluarga atau bahkan pengetahuan yang diperoleh dari lingkungan sosial terbukti dapat mendorong ibu untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan secara lebih optimal. Budaya dianggap ambivalen, karena dapat menjadi penghambat maupun pendorong, tergantung pada bagaimana nilai tersebut berinteraksi dengan sistem pelayanan kesehatan.

Upaya peningkatan pemanfaatan pelayanan kesehatan, khususnya dalam pelayanan ibu dan anak, harus dengan mengintegrasikan pendekatan transkultural yang tidak hanya berfokus pada aspek medis, tetapi juga memahami aspek sosial budaya dalam masyarakat.

Selain peran budaya dalam menentukan apakah ibu akan memanfaatkan pelayanan kesehatan atau tidak, terdapat konsep tentang tiga fase keterlambatan utama yang menghalangi perempuan mengakses pelayanan maternal neonatal darurat yang dibutuhkan yakni: *three delays model*, sebagai berikut:

1. Keterlambatan dalam mengambil keputusan mencari pertolongan (*Delay in deciding to seek care*)
2. Keterlambatan mencapai fasilitas kesehatan (*Delay in reaching a health facility*)
3. Keterlambatan mendapatkan pelayanan yang sesuai (*Delay in receiving adequate treatment*)

Budaya berpengaruh terutama pada delay pertama, yaitu keputusan untuk mencari pertolongan. Faktor-faktor budaya berikut yang dianggap sebagai menghambat yakni Kepercayaan pada dukun, Kurang percaya pada tenaga kesehatan (masih muda dan belum punya pengalaman melahirkan), Norma sosial yang membatasi akses perempuan, juga akses geografis yang sulit dapat memperkuat ketergantungan pada praktik tradisional.

G. Peran Bidan dalam Menghadapi Pengaruh Budaya terhadap keputusan persalinan

Sebagai tenaga kesehatan yang bertanggung jawab terhadap kesehatan dan keselamatan ibu hamil dan melahirkan, Bidan memiliki peran strategis dalam menjembatani antara praktik budaya dalam kehamilan dan persalinan dengan praktik medis maternal, Pendekatan yang digunakan harus berbasis pada sensitivitas budaya (*cultural sensitivity*).

Beberapa strategi yang dapat dilakukan Bidan

1. Menghargai kepercayaan lokal namun tetap utamakan keselamatan ibu

Menghargai kepercayaan lokal merupakan strategi penting dalam memberikan pelayanan kebidanan, pada masyarakat yang masih memegang teguh nilai budaya tradisional. Pendekatan ini bukan berarti menerima semua praktik budaya, namun mengkombinasikan pelayanan modern dan tradisional yang wajar. Bidan diharapkan menjadi fasilitator yang dapat menyeimbangkan nilai budaya dan prinsip keselamatan kesehatan dan keselamatan ibu. Penelitian menunjukkan bahwa penolakan terhadap praktik budaya secara langsung justru dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap tenaga kesehatan dan menghambat pemanfaatan pelayanan kesehatan formal. Sebaliknya, pendekatan yang menghargai budaya dapat meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap intervensi kesehatan modern. Dalam hal pelayanan maternal, integrasi nilai budaya yang aman dapat membina hubungan terapeutik antara bidan dan ibu hamil serta keluarganya, sehingga ibu menjadi lebih terbuka menerima edukasi kesehatan. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa resistensi terhadap pelayanan kesehatan sering muncul ketika intervensi dianggap bertentangan dengan kepercayaan lokal. Oleh karena itu, pendekatan sensitif budaya menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan keselamatan ibu. (WHO, 2028)

2. Membangun interaksi empati dan komunikasi yang efektif

Gabrysch & Campbell, (2009). Menyatakan bahwa kualitas interaksi antara penyedia layanan dan pasien, termasuk komunikasi yang jelas dan suportif, merupakan determinan penting dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan maternal Komunikasi yang baik meningkatkan pemahaman ibu terhadap manfaat

pelayanan kesehatan, sehingga mendorong perilaku kepatuhan. Komunikasi yang efektif akan berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, sarana penghubung antara bidan dan keluarga untuk membangun kepercayaan dan hubungan interpersonal yang kuat. Interaksi yang penuh empati dapat memberi peluang bidan memahami kebutuhan fisiologis, psikologis, dan sosial ibu hamil, sehingga intervensi yang diberikan menjadi lebih tepat sasaran.

Komunikasi yang efektif diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan ibu terhadap anjuran kesehatan, termasuk kunjungan antenatal dan konsumsi suplemen. Selain itu, komunikasi yang empatik dalam menjelaskan praktik medis dengan bahasa yang dapat diterima oleh masyarakat, akan mengurangi kesenjangan antara sistem kesehatan modern dan kepercayaan tradisional dapat mengurangi kecemasan ibu dan meningkatkan pengalaman positif selama kehamilan dan persalinan.

3. Melibatkan keluarga dalam edukasi kesehatan

Pada sebagian besar masyarakat Indonesia, keputusan terkait kesehatan ibu tidak sepenuhnya berada pada ibu, melainkan dipengaruhi oleh keluarga, terutama suami dan orang tua. Karena itu, sangatlah penting bidan dalam edukasi kesehatan perlu melibatkan keluarga sehingga keluarga memahami pentingnya pelayanan kesehatan yang tepat dalam menangani kesehatan ibu hamil. Dengan strategi ini diharapkan dapat membantu dalam meningkatkan pemanfaatan pelayanan kesehatan.

Chairiyah, R., Aprilyani, R., & Muhammad, M. (2025), menemukan bahwa dukungan keluarga berpengaruh signifikan terhadap keputusan ibu dalam memanfaatkan pelayanan antenatal, persalinan di fasilitas kesehatan, serta kepatuhan terhadap intervensi medis. Ketika keluarga memahami pentingnya pelayanan kesehatan, mereka cenderung mendorong ibu untuk mengikuti anjuran tenaga kesehatan. Sebaliknya, kurangnya dukungan keluarga dapat menjadi hambatan utama dalam akses layanan kesehatan.

4. Kolaborasi Bidan dengan dukun beranak (Kemitraan Bidan-Dukun)

Kemitraan antara bidan dengan dukun beranak yang masih diterapkan di beberapa daerah di Indonesia terbukti dapat membina komitmen bersama untuk bekerja sama dalam meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan ibu bersalin. Pendekatan kolaboratif antara bidan dan dukun terbukti dapat meningkatkan cakupan persalinan aman dan mengurangi risiko komplikasi.

Praktik Kemitraan Dukun dan bidan di Kalimantan Selatan, dibuat dengan nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*) yang diketahui oleh pemerintah desa. Sehingga, para dukun akan mendapat insentif setiap kali merujuk ibu bersalin ke fasilitas kesehatan. Dengan begitu, Dukun tidak merasa

kehilangan mata pencaharian, dan mendapatkan penghasilan atas jasa merujuk pasien. Tidak hanya itu, Dukun juga berperan untuk memberikan informasi asupan gizi seimbang pada ibu hamil untuk mencegah Stunting. Bentuk apresiasi kepada Dukun tidak hanya ditunjukkan melalui insentif, tapi juga dengan memberikan beasiswa pada anak dukun untuk disekolahkan di Institusi kesehatan, dengan harapan setelah selesai dikembalikan ke tempat asalnya dan bekerja sebagai tenaga kesehatan.

Perlunya pembinaan dalam praktik kolaborasi, terutama dalam pelayanan kesehatan ibu dapat membantu meningkatkan pelayanan kesehatan lebih efisien, pelayanan yang lebih terpusat pada pasien, komunikasi yang lebih efektif, dan perawatan yang berkesinambungan. Selain itu, praktik kolaboratif interprofesional mampu meningkatkan kualitas keselamatan pasien, karena adanya pengembangan budaya keselamatan dan perawatan yang berpusat pada pasien, hal ini dapat membantu meningkatkan pelayanan kesehatan pada ibu hamil dengan budaya yang kompleks (Shitah, S. A. F., & Astuti, I. (2025).

H. Contoh Kasus (Kontekstual Indonesia Timur)

Kasus: Persalinan di Pulau Terpencil Maluku Utara

Seorang ibu hamil dari pulau terpencil di Kabupaten Kepulauan Sula, memilih melahirkan di rumah dengan bantuan dukun kampung, meskipun sejak kehamilannya memasuki triwulan ketiga, bidan sudah menyarankan untuk melahirkan di Rumah Sakit di ibu kota Kabupaten, dengan menjelaskan keadaan ibu yang anemia berat dengan segala akibatnya, Keputusan ibu dan keluarga melahirkan ditolong dukun, dipengaruhi oleh:

1. Kepercayaan keluarga terhadap dukun
2. Tradisi turun temurun dimana memotong tali pusat tidak boleh menggunakan logam, harus sembilu.
3. Akses transportasi yang sulit ke fasyankes
4. Kekhawatiran terhadap biaya dan prosedur medis

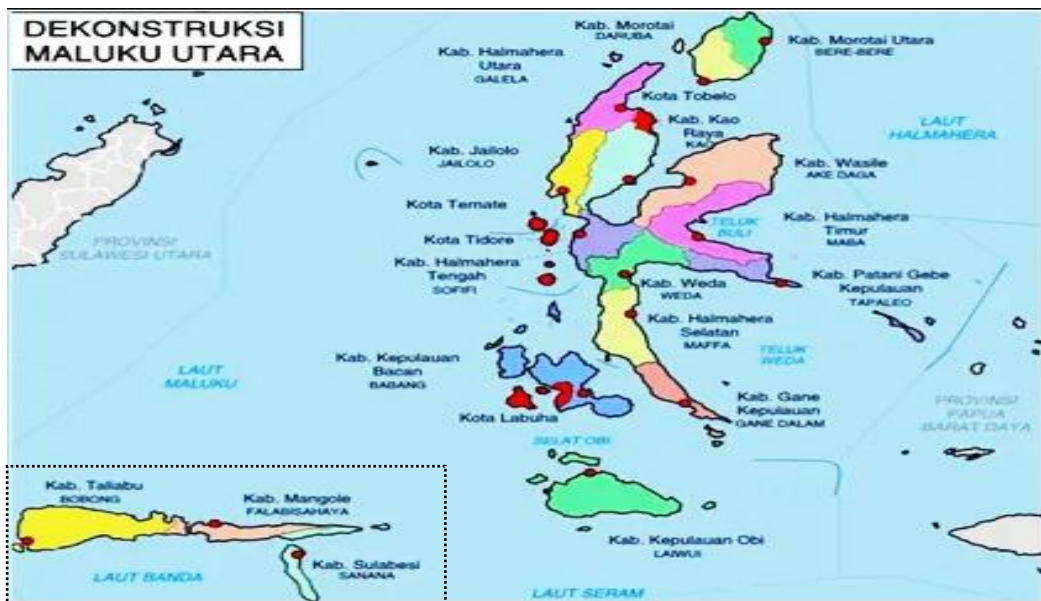
Saat persalinan, terjadi komplikasi perdarahan. Ibu akhirnya dibawa ke Puskesmas terdekat, meskipun keadaan laut bergelombang. Karena terlambat ke fasilitas pelayanan kesehatan dan jarak tempuh antar pulau menyebabkan kondisi ibu memburuk sebelum mencapai fasilitas kesehatan.

Analisis:

Kasus diatas menunjukkan bahwa

1. Dominasi keluarga dalam pengambilan keputusan (budaya lokal).
2. Terjadinya delay pertama dan kedua (terlambat mengambil keputusan dan terlambat mencapai fasilitas pelayanan kesehatan)

3. Rendahnya integrasi antara layanan kesehatan dan budaya lokal



Gambar 3.1 Peta Maluku utara

Pembelajaran:

- a. Pentingnya pendekatan budaya dalam edukasi kesehatan
- b. Perlunya penguatan sistem rujukan di daerah terpencil
- c. Kolaborasi dengan tokoh lokal sebagai strategi efektif

Gambar peta Provinsi Maluku Utara sumber Journal Telegraf.com

Ket: Peta Kabupaten Kepulauan Sula

I. Penutup

Budaya memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap keputusan persalinan di masyarakat Indonesia. Nilai, kepercayaan, dan praktik budaya dapat menjadi faktor pendukung maupun penghambat dalam upaya peningkatan persalinan aman.

Karena itu, tenaga kesehatan, khususnya bidan, perlu memiliki kompetensi dalam memahami dan mengintegrasikan aspek budaya dalam praktik pelayanan kebidanan. Pendekatan yang sensitif budaya tidak hanya meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, tetapi juga berkontribusi pada penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Strategi yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan layanan kesehatan di desa adalah dengan:

Pendidikan kesehatan pada masyarakat, terutama kesehatan maternal neonatal, subsidi transportasi dari Pemda dapat mendorong masyarakat menggunakan fasilitas kesehatan, kolaborasi bidan dengan dukun lokal membangun kemitraan yang saling menguntungkan. Program Desa Siaga Aktif juga efektif mengintegrasikan layanan modern dengan nilai budaya setempat.

Referensi

- Actis Danna, V., Bedwell, C., Wakasiaka, S., & Lavender, T. (2020). Utility of the three-delays model and its potential for supporting a solution-based approach to accessing intrapartum care in low-and middle-income countries. A qualitative evidence synthesis. *Global health action*, 13(1), 1819052.
- Aderi, A., Prabandari, Y. S., & Tri Ratnawati, A. (2016). Merasa aman karena dianggap normal, kemudahan dan kepasrahan sebagai alasan ibu-ibu memilih persalinan rumah di desa: Studi kualitatif di Kalimantan Tengah. *Berita Kedokteran Masyarakat*, 32(6), 203
- Ahmad, A. D., Hanita, M., & Nurhasana, R. (2025). Hambatan Sosial Budaya dalam Pelayanan Kesehatan pada Komunitas Tradisional: Studi Literatur. *ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial dan Budaya*, 14(3), 383-400.
- Andia, F. (2019). Hubungan Budaya, Keterjangkauan dan Prasarana Serta Persepsi Ibu Terhadap Perilaku Pemilihan Pertolongan Persalinan di Kecamatan Warung Gunung Kabupaten Lebak-banten. *Jurnal Obstetika Scientia*, 7(1), 381-399.
- Aryastami, N. K., & Mubasyiroh, R. (2019). Peran Budaya dalam Pemanfaatan Layanan Kesehatan Ibu Hamil. *Kemenkes RI, November*, 1-7.
- Bakoil, M. B., & Diaz, M. F. (2020). Pengaruh pengambilan keputusan, dukungan suami dan faktor budaya terhadap lamanya proses persalinan di Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2019. *Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes*, 11, 107-111.
- Chairiyah, R., Aprilyani, R., & Muhammad, M. (2025). Peran Keluarga dan Dukungan Emosional dalam Pengambilan Keputusan Pertolongan Persalinan di Fasilitas Kesehatan Kelurahan Rancamaya Bogor. *Jurnal Abdi Insani*, 12(5), 2316-2323.
- Gabrysch, S., & Campbell, O. M. R. (2009). Still too far to walk: Literature review of the determinants of delivery service use. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 9(1), 34
- Hamid, H., Ramli, R., & Ishak, S. N. (2022). Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penolong Persalinan di Desa Manatahan Kecamatan Obi Barat. *Jurnal Biosainstek*, 4(2), 46-51
- Herwansyah, H., Czabanowska, K., Kalaitzi, S., & Schröder-Bäck, P. (2024). Understanding Interpersonal Influences on Maternal Health Service Utilization at Community Health Centers: A Mixed-Methods Study in Indonesia. *Healthcare (Basel, Switzerland)*, 13(1), 42. <https://doi.org/10.3390/healthcare13010042>

- Kurnaesih, E., Multazam, A., & Sudarsa, C. (2018). Persepsi Ibu Hamil tentang Pemilihan Persalinan ditinjau dari Budaya Banggai di Wilayah Kerja Puskesmas Lantibung. *Jurnal Mitrsehat*, 8(2).
- Lestari, S., Hermayanti, Y., & Maryati, I. (2023). Dampak Ketakutan Terhadap Proses Intranatal. *Journal of Telenursing (JOTING)*, 5(2), 3128-3136.
- Lestari, W., & Agustina, Z. A. (2018). MENYAMBUT GENERASI BARU DALAM KONTEKS BUDAYA: META ETNOGRAFI BUDAYA PERSALINAN DI INDONESIA. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 20(1), 49-60.
- Marisa, A. (2022). Analisis Jurnal Budaya, Dukungan Keluarga dan Konseling Terhadap Pemilihan Tempat Persalinan: Analysis of Cultural Journals, Family Support, and Counseling on the Choice of Place of Delivery. *Indonesian Scholar Journal of Nursing and Midwifery Science*, 1(10), 378-388.
- Moeda, V. S., Zakaria, F., & Yunus, Y. (2026). FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGGINYA KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP PERTOLONGAN PERSALINAN OLEH DUKUN BAYI DI PUSKESMAS TOLANGOHULA. *Manuntung: Jurnal Ilmu Kesehatan*, 1(1), 8-21.
- Ningrum, W. M., Purnamasari, K. D., & Rohmah, S. (2024). Kearifan Lokal Kagaluhan: Menggali Praktik Tradisional Kesehatan Ibu Melahirkan di Kampung Naga. *Journal of Midwifery and Public Health*, 4(2), 68-74.
- Nuraini, N., Brata, Y. R., & Budiman, A. (2025). Values of Local Wisdom in the Traditional Tingkeban Ceremony Among the Jawa-Pangandaran Ethnic Group. *JAMASAN: Jurnal Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 1(3), 309-327.
- Shitah, S. A. F., & Astuti, I. (2025). PROGRAM INOVASI PENGABDIAN MASYARAKAT: "SI-KESDUDES (Sinergitas Tenaga Kesehatan, Dukun Bersalin Dan Perangkat Desa) Dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Di Kecamatan Bukit Raya Kalimantan Tengah. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Kebidanan*, 7(2), 16-26.
- Sipahutar, N. (2018). *Kepercayaan Ibu Hamil Memilih Persalinan ke Dukun Beranak di Desa Sibito Kecamatan Aek Natas* (Doctoral dissertation, UNIMED).
- World Health Organization. (2018). *WHO recommendations: Intrapartum care for a positive childbirth experience*. Geneva: WHO
- Yani, V. D., Emilia, O., & Kusnanto, H. (2014). Persepsi Remaja Terhadap Faktor Penghambat Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Di Puskesmas Gambok Kabupaten Sijunjung. *J. Kesehat. Reproduksi*, 1(1).

Yogi, R., Hijjang, P., Poli, A. I., & Numberi, G. K. I. (2025). Praktik Kesehatan Reproduksi Perempuan Suku Asmat: Tinjauan Sosial Budaya. *Jurnal Ekologi Birokrasi*, 13(1), 42-48.

BAB IV

KOMUNIKASI TERAPEUTIK PADA IBU DAN KELUARGA

A. Pendahuluan

Komunikasi terapeutik merupakan salah satu keterampilan penting dalam praktik pelayanan kesehatan, khususnya dalam asuhan kepada ibu dan keluarga. Komunikasi terapeutik tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk penyampaian informasi, tetapi juga sebagai alat untuk membangun hubungan yang saling percaya antara tenaga kesehatan dengan pasien dan keluarganya. Dalam konteks pelayanan kebidanan dan kesehatan keluarga, komunikasi terapeutik berperan dalam membantu ibu untuk memahami kondisi kesehatannya, mengurangi kecemasan, serta meningkatkan partisipasi keluarga dalam proses perawatan dan pengambilan keputusan (Restu Pertiwi et al. 2022).

Keluarga sebagai sistem pendukung yang utama memiliki peran penting dalam keberhasilan perawatan ibu, sehingga keterlibatan mereka melalui komunikasi yang efektif menjadi hal yang sangat diperlukan. Terutama dalam masa kehamilan, persalinan, dan nifas, sering mengalami perubahan fisik dan psikologis yang signifikan. Tanpa komunikasi yang baik, informasi yang diberikan dapat disalahartikan, menimbulkan ketidakpercayaan, bahkan berpotensi menghambat proses penyembuhan (Norlina 2021).

Prinsip penting dari komunikasi terapeutik mencakup empati, kejujuran, keterbukaan, serta kemampuan mendengarkan secara aktif. Tenaga kesehatan dituntut untuk mampu menyesuaikan gaya komunikasi dengan latar belakang sosial, budaya, dan tingkat pendidikan ibu serta keluarganya. Hal ini penting terutama di masyarakat yang memiliki nilai-nilai budaya kuat dalam pengambilan keputusan kesehatan (Widiyanto et al. 2024).

Pemahaman dan keterampilan komunikasi terapeutik menjadi kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh setiap tenaga kesehatan, khususnya dalam bidang kebidanan dan kesehatan masyarakat. Penerapan komunikasi terapeutik yang efektif tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, tetapi juga berdampak pada kepuasan pasien, kepatuhan terhadap terapi, serta hasil kesehatan ibu dan keluarga secara keseluruhan (RI 2020).

B. Komunikasi Terapeutik Pada Ibu dan Keluarga

1. Konsep Dasar

Komunikasi adalah suatu alat yang penting dalam membina hubungan terapeutik dan dapat memengaruhi kualitas suatu pelayanan (Fatimah 2022). Terapeutik merupakan kata sifat yang dihubungkan dengan seni penyembuhan. Dalam hal ini, dapat diartikan terapeutik adalah segala sesuatu yang memfasilitasi proses penyembuhan. Dengan demikian dapat disimpulkan komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang dirancang dan direncanakan untuk tujuan terapi, dalam rangka membina hubungan antara perawat dengan pasien agar dapat beradaptasi dengan stress, mengatasi gangguan psikologis, sehingga dapat melegakan serta membuat pasien merasa nyaman, yang dapat mempercepat proses kesembuhan pasien (Suprayitno 2023). Dalam konteks ibu dan keluarga, komunikasi terapeutik menjadi sarana untuk membangun hubungan saling percaya antara tenaga kesehatan dan ibu sebagai penerima asuhan keluarga yang merupakan sistem pendukung utama.

Komunikasi terapeutik memiliki karakteristik yang berbeda dari komunikasi biasa. Tenaga kesehatan bukan hanya sekadar berbicara atau memberi instruksi, tetapi juga mendengarkan secara aktif, menunjukkan empati, memahami perasaan klien, dan memberikan respons yang mendukung. Proses ini dilakukan secara terencana, berorientasi pada kebutuhan ibu dan keluarga serta mempertimbangkan aspek emosional, sosial, budaya dan spiritual (Muna 2021). Pada pelayanan kesehatan ibu, komunikasi terapeutik sangat penting karena ibu sering berada dalam situasi rentan. Seorang ibu hamil dapat merasa cemas terhadap kondisi janinnya, ibu bersalin dapat merasa takut terhadap nyeri atau komplikasi, dan ibu nifas dapat mengalami kelelahan fisik maupun perubahan emosional. Dalam situasi tersebut, komunikasi yang baik dapat menjadi bentuk intervensi yang menenangkan dan memberi kekuatan psikologis (Novitasari 2025).

Konsep dasar komunikasi terapeutik juga mencakup hubungan terapeutik, yaitu tahapan pra-interaksi, orientasi, kerja, dan terminasi. Pada tahapan pra-interaksi, tenaga kesehatan mempersiapkan diri sebelum bertemu klien, termasuk memahami data dasar ibu dan keluarganya. Pada tahap orientasi, dibangun hubungan awal melalui pengenalan, penjelasan tujuan, dan penciptaan rasa percaya. Tahap kerja merupakan inti dari proses komunikasi, yaitu ketika tenaga kesehatan menggali masalah, memberikan dukungan, edukasi, dan membantu pemecahan masalah. Tahap terminasi adalah tahap penutupan interaksi, yaitu menyimpulkan hasil komunikasi dan mempersiapkan tindak lanjut (Teguh Wahyudi 2025).

Komunikasi terapeutik tidak hanya dipahami sebagai keterampilan berbicara, tetapi sebagai kompetensi profesional yang mencakup sikap, pengetahuan dan kemampuan membangun hubungan yang membantu ibu dan keluarga menghadapi situasi kesehatan secara lebih adaptif.

2. Prinsip

Komunikasi terapeutik pada ibu dan keluarga perlu didasarkan pada sejumlah prinsip agar interaksi yang terjalin benar-benar memberikan dampak positif. Salah satu prinsip utama adalah empati, yaitu kemampuan tenaga kesehatan untuk memahami perasaan, pengalaman, dan kebutuhan ibu tanpa bersikap menghakimi. Sikap empatik akan membuat ibu merasa dipahami dan diterima, sehingga ibu lebih terbuka dalam mengungkapkan keluhan maupun kekhawatirannya (Suprayitno 2023).

Prinsip kedua adalah menghargai martabat dan otonomi klien. Dalam praktek pelayanan kesehatan, ibu perlu diperlakukan sebagai individu yang memiliki hak untuk memperoleh informasi mengenai kondisi kesehatannya, menyampaikan pendapat, serta berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. Keluarga juga perlu dipandang sebagai bagian penting dari sistem pendukung ibu. Namun, keterlibatan keluarga harus tetap memperhatikan dan menghormati hak ibu sebagai fokus utama dalam pelayanan kesehatan (Arthanti et al. 2025).

Prinsip ketiga adalah kejujuran dan keterbukaan dalam berkomunikasi. Informasi yang disampaikan kepada ibu dan keluarga harus bersifat benar, jelas, serta menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Komunikasi yang jujur berperan penting dalam membangun rasa percaya antara tenaga kesehatan, ibu, dan keluarga. Sebaliknya, penyampaian informasi yang kurang jelas, tidak lengkap, atau menyesatkan dapat menimbulkan kecemasan, kesalahpahaman, serta menurunkan kualitas hubungan terapeutik (Karim 2025).

Prinsip keempat adalah menjaga kerahasiaan. Setiap informasi pribadi yang disampaikan oleh ibu dan keluarga harus dijaga dengan penuh tanggung jawab serta tidak disebarluaskan tanpa persetujuan yang bersangkutan. Penerapan prinsip kerahasiaan sangat penting untuk menciptakan rasa aman dan nyaman, sehingga klien memiliki keberanian untuk mengungkapkan kondisi, keluhan, maupun permasalahan yang dialaminya secara jujur dan terbuka (Ardiansyah 2022).

Prinsip kelima adalah berfokus pada kebutuhan klien. Dalam komunikasi terapeutik, kebutuhan ibu dan keluarga harus ditempatkan sebagai pusat perhatian dalam setiap proses pelayanan. Tenaga kesehatan perlu menyesuaikan cara berkomunikasi dengan karakteristik klien, seperti usia, tingkat pendidikan,

kondisi emosional, latar belakang budaya, serta situasi klinis yang sedang dihadapi. Dengan demikian, komunikasi yang terjalin dapat lebih efektif, mudah dipahami, dan sesuai dengan kebutuhan klien (Riskha 2024).

Prinsip keenam adalah kesabaran dan penerimaan. Dalam pelaksanaan komunikasi terapeutik, tidak semua ibu dan keluarga mampu memahami informasi atau menerima kondisi kesehatan yang dialami secara langsung. Oleh karena itu, tenaga kesehatan perlu menunjukkan sikap sabar, tidak terburu-buru, serta mampu menerima respons klien sebagaimana adanya. Sikap tersebut penting untuk menciptakan suasana komunikasi yang aman, nyaman, dan mendukung proses adaptasi klien terhadap kondisi yang dihadapi (Mundakir 2016).

Prinsip ketujuh adalah konsistensi antara komunikasi verbal dan nonverbal. Dalam komunikasi terapeutik, pesan yang disampaikan melalui kata-kata harus selaras dengan ekspresi wajah, intonasi suara, dan bahasa tubuh tenaga kesehatan. Ucapan yang menenangkan perlu didukung oleh ekspresi wajah yang ramah, nada suara yang lembut, serta sikap tubuh yang terbuka. Ketidaksesuaian antara pesan verbal dan nonverbal dapat menimbulkan kebingungan, keraguan, bahkan menurunkan kepercayaan klien terhadap tenaga kesehatan (Muhith 2018).

Prinsip kedelapan adalah sensitivitas terhadap budaya dan nilai keluarga. Setiap keluarga memiliki kebiasaan, keyakinan, bahasa, serta pola pengambilan keputusan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, komunikasi terapeutik perlu dilakukan dengan menghormati perbedaan tersebut agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Sikap peka terhadap budaya dan nilai keluarga juga penting untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman, penolakan, atau resistensi dalam proses pelayanan kesehatan (Mundakir 2016).

3. Teknik

Teknik komunikasi terapeutik merupakan cara yang digunakan oleh tenaga kesehatan untuk membangun hubungan yang efektif dengan ibu dan keluarga. Salah satu teknik yang sangat penting dalam komunikasi terapeutik adalah mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif berarti memberikan perhatian secara penuh ketika ibu menyampaikan keluhan, perasaan, atau pengalamannya. Tenaga kesehatan perlu menghindari sikap memotong pembicaraan serta menunjukkan bahwa setiap keluhan dan perasaan klien benar-benar didengarkan, dihargai, dan diperhatikan.

Teknik berikutnya adalah mengajukan pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka, seperti "Bagaimana perasaan Ibu hari ini?" atau "Apa hal yang paling Ibu khawatirkan saat ini?", memberikan kesempatan kepada ibu untuk

mengungkapkan pikiran, perasaan, dan pengalamannya secara lebih luas. Teknik ini lebih efektif dalam menggali informasi dibandingkan dengan pertanyaan tertutup, karena tidak hanya menghasilkan jawaban singkat, tetapi juga mendorong klien untuk bercerita secara lebih terbuka (Kiki M 2020).

Refleksi juga merupakan salah satu teknik penting dalam komunikasi terapeutik. Teknik ini dilakukan dengan cara mengulang atau menyatakan kembali inti perasaan maupun pernyataan yang disampaikan oleh klien. Sebagai contoh, ketika ibu menyampaikan bahwa ia merasa takut menghadapi persalinan, tenaga kesehatan dapat memberikan respons, "Ibu merasa cemas karena belum mengetahui apa yang akan terjadi saat proses persalinan." Melalui teknik refleksi, ibu akan merasa lebih dipahami, dihargai, dan didukung dalam menghadapi kondisi yang dialaminya.

Teknik lainnya adalah klarifikasi, yaitu upaya untuk memperjelas informasi yang belum lengkap atau belum sepenuhnya dipahami. Klarifikasi penting dilakukan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman antara tenaga kesehatan dan klien. Sebagai contoh, ketika ibu menyampaikan keluhan dengan istilah yang masih bersifat umum, tenaga kesehatan dapat mengajukan pertanyaan lanjutan secara sopan agar makna keluhan tersebut menjadi lebih jelas dan dapat dipahami dengan tepat (Ulfah 2023).

Memberikan informasi merupakan salah satu teknik yang sangat sering digunakan dalam pelayanan maternal. Informasi yang disampaikan harus bersifat singkat, jelas, sesuai dengan kebutuhan klien, dan tidak berlebihan. Penjelasan mengenai prosedur pelayanan, tanda bahaya, perawatan diri, maupun kondisi bayi perlu disampaikan dengan bahasa yang sederhana agar mudah dipahami oleh ibu dan keluarga. Teknik diam terapeutik juga dapat digunakan dalam komunikasi terapeutik. Pada situasi tertentu, diam bukan berarti pasif, melainkan menjadi cara untuk memberikan ruang kepada ibu dalam mengungkapkan perasaan, menangis, atau berpikir dengan lebih tenang. Kehadiran tenaga kesehatan secara penuh dalam suasana hening sering kali memiliki makna yang lebih mendalam daripada banyaknya kata-kata yang disampaikan.

Selain itu, pemberian penguatan atau *reinforcement* merupakan teknik yang bertujuan untuk meningkatkan rasa percaya diri ibu. Penguatan dapat diberikan melalui pernyataan yang positif dan mendukung, seperti "Ibu sudah berusaha dengan sangat baik," atau "Keputusan Ibu untuk segera memeriksakan diri merupakan langkah yang tepat." Teknik ini dapat membantu ibu merasa lebih yakin, dihargai, dan didukung dalam menghadapi kondisi yang dialaminya. Komunikasi nonverbal, seperti kontak mata yang tepat, sentuhan terapeutik yang sesuai, sikap tubuh yang terbuka, dan ekspresi wajah yang hangat, sangat

mendukung keberhasilan komunikasi terapeutik. Dalam konteks pelayanan kepada ibu dan keluarga, pesan nonverbal sering kali lebih cepat ditangkap dan dimaknai dibandingkan dengan pesan verbal. Oleh karena itu, tenaga kesehatan perlu memperhatikan keselarasan antara ucapan, sikap, dan ekspresi yang ditampilkan selama proses komunikasi berlangsung (Palifiana et al. 2020).

4. Pembahasan

Komunikasi terapeutik pada ibu dan keluarga memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam pelayanan kesehatan maternal. Keberhasilan asuhan tidak hanya ditentukan oleh ketepatan tindakan klinis, tetapi juga oleh kualitas hubungan yang terjalin antara tenaga kesehatan, ibu, dan keluarga. Hubungan yang baik dapat meningkatkan rasa aman, kepercayaan, serta kerja sama dalam proses pelayanan. Pada masa kehamilan, komunikasi terapeutik berperan penting dalam membantu ibu memahami berbagai perubahan fisik dan emosional yang dialaminya. Banyak ibu hamil, terutama primigravida, mengalami kecemasan terhadap kondisi janin, proses persalinan, maupun kemampuan dalam menjalankan peran sebagai ibu. Apabila tenaga kesehatan memberikan kesempatan kepada ibu untuk mengungkapkan perasaannya, menjelaskan kondisi kehamilan secara jelas, serta melibatkan keluarga dalam proses edukasi, ibu akan cenderung merasa lebih tenang dan lebih siap dalam menghadapi kehamilan serta persalinan.

Pada masa persalinan, komunikasi terapeutik memiliki peran yang sangat penting karena ibu berada dalam kondisi nyeri, tegang, dan rentan secara emosional. Penyampaian kata-kata yang menenangkan, pemberian penjelasan singkat mengenai prosedur yang akan dilakukan, serta kehadiran tenaga kesehatan yang suportif dapat membantu ibu merasa lebih aman dan tidak sendirian dalam menjalani proses persalinan. Dukungan verbal, seperti memberikan motivasi, menjelaskan perkembangan persalinan, dan menghargai setiap usaha ibu selama proses persalinan, dapat meningkatkan kemampuan ibu dalam menghadapi nyeri dan stres. Dengan demikian, komunikasi terapeutik tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai bentuk dukungan emosional yang membantu ibu menjalani persalinan dengan lebih tenang dan percaya diri.

Pada masa nifas, komunikasi terapeutik tetap diperlukan karena ibu sedang mengalami proses pemulihan fisik, penyesuaian terhadap peran baru, perubahan pola tidur, kelelahan, serta kemungkinan perubahan suasana hati. Dalam kondisi tersebut, tenaga kesehatan perlu memiliki kepekaan terhadap tanda-tanda stres, *baby blues*, maupun kecemasan ibu dalam merawat bayi. Komunikasi yang empatik dapat membantu ibu merasa aman untuk bertanya, mengungkapkan

perasaan, dan berbagi pengalaman. Hal ini mencakup berbagai permasalahan yang mungkin dialami ibu, seperti kesulitan menyusui, kelelahan, atau kekhawatiran terhadap kondisi bayinya. Dengan demikian, komunikasi terapeutik pada masa nifas berperan penting dalam memberikan dukungan emosional, meningkatkan rasa percaya diri ibu, serta membantu proses adaptasi ibu dalam menjalankan peran sebagai orang tua.

Keluarga, khususnya suami, memiliki peran sentral dalam memberikan dukungan kepada ibu. Namun, dalam praktiknya, tidak semua keluarga memahami kebutuhan ibu secara menyeluruh. Sebagian keluarga cenderung terlalu dominan dalam pengambilan keputusan, sebagian lainnya kurang memberikan dukungan emosional, dan ada pula keluarga yang masih kuat dipengaruhi oleh mitos atau kebiasaan tertentu. Dalam kondisi tersebut, komunikasi terapeutik perlu diarahkan tidak hanya untuk memberikan penjelasan, tetapi juga untuk membangun kesadaran keluarga mengenai pentingnya dukungan fisik, emosional, dan sosial bagi ibu. Melalui komunikasi yang tepat, keluarga diharapkan mampu menjadi sumber dukungan yang positif, sehingga ibu merasa lebih aman, dihargai, dan didampingi dalam menjalani masa kehamilan, persalinan, maupun nifas.

Pelibatan keluarga melalui komunikasi terapeutik dapat meningkatkan kepatuhan ibu dan keluarga terhadap anjuran kesehatan. Keluarga yang memahami tanda bahaya kehamilan, misalnya, akan lebih cepat mengambil keputusan untuk membawa ibu ke fasilitas pelayanan kesehatan. Demikian pula, keluarga yang memperoleh edukasi mengenai pentingnya ASI eksklusif akan cenderung memberikan dukungan yang lebih optimal kepada ibu dalam proses menyusui.

Selain itu, keluarga yang memahami kondisi psikologis ibu pada masa nifas akan lebih peka terhadap kebutuhan ibu, baik dalam hal istirahat, dukungan emosional, maupun penghargaan terhadap peran ibu. Dengan demikian, komunikasi terapeutik tidak hanya ditujukan kepada ibu, tetapi juga kepada keluarga sebagai sistem pendukung utama. Dukungan keluarga yang baik dapat membantu ibu menjalani masa kehamilan, persalinan, dan nifas dengan lebih aman, nyaman, serta percaya diri (Fadjriah 2021).

Meski demikian, penerapan komunikasi terapeutik pada ibu dan keluarga tidak terlepas dari berbagai hambatan. Hambatan tersebut dapat berasal dari ibu, keluarga, tenaga kesehatan, maupun lingkungan pelayanan. Dari sisi ibu, hambatan dapat muncul akibat nyeri, kelelahan, kecemasan, atau keterbatasan pemahaman terhadap informasi kesehatan yang diberikan. Hambatan juga dapat berasal dari keluarga, seperti adanya perbedaan persepsi, rendahnya literasi

kesehatan, dominasi anggota keluarga tertentu dalam pengambilan keputusan, serta pengaruh nilai budaya atau kebiasaan yang kurang sesuai dengan prinsip kesehatan. Dari sisi tenaga kesehatan, hambatan dapat berupa tingginya beban kerja, keterbatasan waktu, kelelahan, serta kurangnya pelatihan dalam komunikasi interpersonal. Selain itu, lingkungan pelayanan yang kurang kondusif, seperti suasana yang bising, ruang pelayanan yang sempit, dan terbatasnya privasi, juga dapat mengurangi efektivitas komunikasi terapeutik (Appiah 2023).

Oleh karena itu, komunikasi terapeutik perlu didukung oleh kesiapan tenaga kesehatan, keterlibatan keluarga, serta lingkungan pelayanan yang nyaman dan menghargai privasi ibu. Upaya ini penting agar proses komunikasi dapat berlangsung secara terbuka, empatik, dan efektif dalam mendukung keselamatan serta kenyamanan ibu selama memperoleh pelayanan kesehatan.

Selain peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan juga perlu menciptakan lingkungan yang mendukung privasi, kenyamanan, dan keamanan psikologis bagi ibu. Lingkungan pelayanan yang kondusif akan membantu proses komunikasi berlangsung lebih terbuka, tenang, dan efektif. Hal lain yang tidak kalah penting adalah penguatan pendekatan pelayanan yang berpusat pada ibu dan keluarga. Melalui pendekatan ini, interaksi antara tenaga kesehatan, ibu, dan keluarga tidak hanya berorientasi pada prosedur klinis, tetapi juga memperhatikan kebutuhan manusiawi klien, seperti rasa dihargai, didengarkan, dipahami, dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Komunikasi terapeutik perlu dipandang sebagai bagian integral dari mutu pelayanan kesehatan maternal. Komunikasi yang baik dapat memperkuat hubungan antara tenaga kesehatan dan klien, meningkatkan kepercayaan, serta mendukung tercapainya pelayanan yang aman, bermartabat, dan berorientasi pada kebutuhan ibu serta keluarga (Kwame 2021).

Dalam perspektif yang lebih luas, komunikasi terapeutik merupakan bagian penting dari pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkeadilan. Ibu dan keluarga yang merasa dihargai akan cenderung memiliki kepercayaan yang lebih tinggi terhadap layanan kesehatan, lebih aktif berpartisipasi dalam proses pelayanan, serta lebih terbuka dalam menerima edukasi kesehatan. Komunikasi terapeutik adalah salah satu kompetensi inti yang harus dimiliki oleh tenaga kesehatan. Kompetensi ini berperan penting dalam mewujudkan asuhan maternal yang holistik, aman, manusiawi, dan berorientasi pada kebutuhan ibu serta keluarga sebagai klien.

C. Penutup

Komunikasi terapeutik pada ibu dan keluarga merupakan komponen penting dalam pelayanan kesehatan maternal. Komunikasi ini berfungsi untuk membangun hubungan saling percaya, mengurangi kecemasan, meningkatkan pemahaman, serta mendorong partisipasi aktif ibu dan keluarga dalam proses asuhan. Komunikasi terapeutik tidak hanya berperan sebagai sarana pertukaran informasi, tetapi juga sebagai bentuk intervensi yang mendukung kondisi psikologis ibu. Selain itu, komunikasi yang dilakukan secara empatik dan efektif dapat memperkuat peran keluarga sebagai sumber dukungan utama bagi ibu selama masa kehamilan, persalinan, nifas, maupun dalam perawatan bayi.

Pelaksanaan komunikasi terapeutik harus didasarkan pada prinsip empati, penghargaan terhadap martabat klien, kejujuran, kerahasiaan, kesabaran, sensitivitas budaya, serta kesesuaian antara pesan verbal dan nonverbal. Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar penting dalam membangun hubungan yang saling percaya antara tenaga kesehatan, ibu, dan keluarga. Berbagai teknik komunikasi terapeutik dapat diterapkan untuk menciptakan hubungan terapeutik yang efektif. Teknik tersebut meliputi mendengarkan secara aktif, mengajukan pertanyaan terbuka, melakukan refleksi, memberikan klarifikasi, menyampaikan informasi secara jelas, menggunakan diam terapeutik, serta memberikan penguatan positif. Penerapan teknik-teknik tersebut secara tepat dapat membantu ibu dan keluarga merasa dihargai, dipahami, dan dilibatkan dalam proses asuhan.

Dalam praktik pelayanan kesehatan maternal, komunikasi terapeutik memberikan manfaat yang besar pada masa kehamilan, persalinan, nifas, serta perawatan bayi baru lahir. Melalui komunikasi yang empatik dan efektif, ibu serta keluarga dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik, merasa lebih aman, dan terdorong untuk berpartisipasi aktif dalam proses asuhan. Namun, penerapan komunikasi terapeutik juga menghadapi berbagai hambatan yang dapat berasal dari ibu, keluarga, tenaga kesehatan, maupun lingkungan pelayanan. Peningkatan kualitas komunikasi terapeutik memerlukan dukungan kompetensi tenaga kesehatan, ketersediaan waktu yang memadai, serta sistem pelayanan yang kondusif, nyaman, dan menghargai privasi klien.

Dengan demikian, komunikasi terapeutik pada ibu dan keluarga perlu dipahami sebagai bagian integral dari asuhan maternal yang holistik. Pelayanan kesehatan yang efektif tidak hanya ditentukan oleh ketepatan tindakan klinis, tetapi juga oleh kemampuan tenaga kesehatan dalam menghadirkan komunikasi yang manusiawi, suportif, dan bermakna. Melalui komunikasi terapeutik yang baik, ibu dan keluarga dapat merasa dihargai, didengarkan, serta didukung dalam setiap tahap pelayanan. Oleh karena itu, komunikasi terapeutik menjadi salah satu unsur

penting dalam mewujudkan asuhan maternal yang aman, bermutu, dan berorientasi pada kebutuhan klien.

Referensi

- Appiah, Evans Osei. 2023. "Hambatan Terhadap Praktik Komunikasi Terapeutik Perawat Di Rumah Sakit Distrik Di Ghana." *springer* 22(35). <https://link.springer.com/article/10.1186/s12912-023-01191-2?>
- Ardiansyah. 2022. "Prinsip Etik Pada Tindakan Keperawatan." Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan. https://keslan.kemkes.go.id/view_artikel/69/prinsip-etik-pada-tindakan- (April 20, 2026).
- Arthanti, Widiana Beta, Universitas Pembangunan, Nasional Veteran, and Jawa Timur. 2025. "Prinsip Otonomi Dalam Praktik Kedokteran Di Indonesia." 5(September): 174–87. <https://jhek.hangtuah.ac.id/index.php/jurnal/article/view/249>.
- Fadjriah, Rasyika Nurul. 2021. "Hubungan Antara Dukungan Sosial Keluarga Dan Perilaku Pemberian ASI Eksklusif Di Puskesmas Talise, Indonesia." *oamjms* 9. <https://oamjms.eu/index.php/mjms/article/view/5987?>
- Fatimah, Siti. 2022. "Komunikasi Terapeutik." Kementerian Kesehatan RI. https://keslan.kemkes.go.id/view_artikel/1344/komunikasi-terapeutik (April 14, 2026).
- Karim, Fadillah. 2025. "Peran Orang Tua Dalam Membangun Komunikasi Keluarga Untuk Meningkatkan Moral Gen Z." 5(2): 431–48.
- Kiki M, Intan W. 2020. *Komunikasi Dalam Praktik Kebidanan*. Pekanbaru: Stikes Hang Tuah Pekanbaru.
- Kwame, Abukari. 2021. "Studi Berbasis Literatur Tentang Perawatan Berpusat Pada Pasien Dan Komunikasi Dalam Interaksi Perawat-Pasien: Hambatan, Faktor Pendukung, Dan Jalan Ke Depan." *PubMed Central* 20: 158. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8414690/?>
- Muhith, Abdul. 2018. *Aplikasi Komunikasi Terapeutik Nursing & Health*. ed. Ratih Indah Utami. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Muna, Irmachul. 2021. "Pentingnya Penerapan Komunikasi Terapeutik Pada Keluarga Keluarga Pasien Anak." *RSUP Dr Sardjito Web Page* (0274): 1–3. <https://sardjito.co.id/2021/10/13/pentingnya-penerapan-komunikasi-terapeutik-pada-keluarga-keluarga-pasien-anak/>.
- Mundakir. 2016. *Komunikasi Pelayanan Kesehatan. Pertama*. ed. Tim Indomedia Pustaka. Yogyakarta: Indomedia Pustaka Penerbit & Distributor.

- Norlina, Sri. 2021. "Kecemasan Ibu Bersalin Di Puskesmas Berangas Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021." Vol.6(No.2): 112–15.
- Novitasari, Anis. 2025. Buku Ajar Komunikasi Terapeutik. Pertama. ed. Lili Purnama Sari. Sulawesi Selatan: CV. Sarana Ilmu Indonesia.
- Palifiana, Dheska Arthyka, Nonik Ayu Wantini, Tutik Astuti, and Sitti Khadijah. 2020. Komunikasi Efektif Konseling. ed. M.Kes Dheska Arthyka Palifiana, SST. Yogyakarta: Respati Press.
- Restu Pertiwi, Melinda, MKep Annalia Wardhani, S Kep, and Ns M Kep. 2022. Komunikasi Teratik Dalam Kesehatan. Pertama. ed. Risnawati. Yogyakarta/Makassar: Rizmedia Pustaka Indonesia.
- RI, Kemenkes. 2020. Pedoman Pelayanan Persalinan Antenatal, Nifas, Dan Bayi Baru Lahir. Jakarta: Kemenkes RI. <https://repository.kemkes.go.id/book/122>.
- Riskha, Suryono. 2024. Komunikasi Kesehatan Dan Interpersonal Skill Tenaga Kesehatan. ed. Komarudin. Cirebon: CV. Green Publisher Indonesia.
- Suprayitno, Emdat. 2023. Buku Ajar Komunikasi Terapeutik Keperawatan (Berdarkan Kurikulum Pendidikan Ners Indonesia Tahun 2021). Pertama. Jawa Tengah: Cv. Eureka Media Aksara. <https://repository.penerbiteureka.com/media/publications/567005-pencegahan-dan-pengendalian-infeksi-di-f-f5220b05.pdf>.
- Teguh Wahyudi, Jaena Lydia. 2025. Buku Ajar Komunikasi Keperawatan. ed. La Ode Alifarki. Jawa Tengah: PT Media Pustaka Indo.
- Ulfah, Ayu. 2023. Komunikasi Dalam Kebidanan. Pertama. ed. M.K.M Rahma Juliani Siregar, SST. Padang Sidempuan: PT Inovasi Pratama Internasional.
- Widiyanto, Budi et al. 2024. Buku Ajar Komunikasi Terapeutik Keperawatan. Jakarta Barat: PT Nusantara Fajar Cemerlang.

BAB V

INTEGRASI PRAKTIK TRADISONAL DAN KLINIS

A. Pendahuluan

Pelayanan kebidanan merupakan bagian integral dari sistem kesehatan yang berperan penting dalam menurunkan angka morbiditas dan mortalitas ibu serta bayi. Dalam praktiknya, bidan tidak hanya berhadapan dengan pendekatan klinis berbasis bukti (*evidence-based practice*), tetapi juga dengan praktik tradisional yang telah lama hidup dan berkembang di masyarakat. Praktik tradisional tersebut mencakup penggunaan ramuan herbal, pijat, ritual budaya, serta berbagai kepercayaan yang memengaruhi perilaku kesehatan ibu selama kehamilan, persalinan, nifas, dan perawatan bayi baru lahir.

Di Indonesia dan banyak negara berkembang lainnya, praktik tradisional masih menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Hal ini dipengaruhi oleh faktor budaya, akses terhadap layanan kesehatan, serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap tenaga kesehatan. Dalam beberapa kasus, praktik tradisional memberikan manfaat, seperti meningkatkan kenyamanan ibu, dukungan psikologis, dan memperkuat ikatan sosial. Namun, di sisi lain, terdapat pula praktik yang berpotensi menimbulkan risiko kesehatan apabila tidak dilakukan secara tepat atau tidak terintegrasi dengan pelayanan medis modern.

Pendekatan integratif antara praktik tradisional dan klinis menjadi suatu kebutuhan dalam praktik kebidanan masa kini. Integrasi ini bukan berarti menggabungkan secara sembarangan, melainkan melalui proses seleksi berbasis bukti ilmiah, keamanan, serta nilai budaya yang ada. Bidan dituntut memiliki kompetensi tidak hanya dalam aspek klinis, tetapi juga kemampuan memahami konteks sosial budaya pasien, sehingga dapat memberikan asuhan yang holistik, aman, dan berpusat pada perempuan (*woman-centered care*).

Organisasi kesehatan dunia menekankan pentingnya pemanfaatan pengobatan tradisional secara rasional dalam sistem kesehatan modern. World Health Organization melalui strategi pengobatan tradisional mendorong integrasi praktik tradisional yang aman dan efektif ke dalam sistem pelayanan kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa praktik tradisional tidak dapat diabaikan, melainkan perlu dikelola secara ilmiah dan profesional.

Dalam konteks kebidanan, integrasi ini juga berkaitan erat dengan peningkatan kualitas pelayanan, kepuasan pasien, serta keberhasilan intervensi kesehatan ibu dan anak. Bidan sebagai tenaga kesehatan lini terdepan memiliki peran strategis dalam menjembatani kesenjangan antara praktik tradisional dan klinis. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif mengenai jenis-jenis praktik tradisional, evidensi ilmiahnya, serta strategi integrasi yang tepat dalam praktik kebidanan.

Buku ini disusun untuk memberikan landasan konseptual dan praktis mengenai integrasi praktik tradisional dan klinis dalam kebidanan. Pembahasan mencakup aspek filosofis, budaya, klinis, serta evidence-based practice yang dapat digunakan sebagai acuan bagi mahasiswa, akademisi, maupun praktisi kebidanan. Dengan pendekatan integratif ini, diharapkan pelayanan kebidanan dapat menjadi lebih adaptif, humanistik, dan tetap menjunjung tinggi prinsip keselamatan ibu dan bayi.

B. Konsep Dasar Integrasi Praktik Tradisional Dan Klinis

1. Definisi Integrasi dalam Praktik Kebidanan

Integrasi dalam praktik kebidanan merupakan suatu pendekatan yang menggabungkan praktik tradisional dengan pelayanan klinis modern secara sistematis, aman, dan berbasis bukti (evidence-based practice). Integrasi ini tidak sekadar mengkombinasikan dua pendekatan yang berbeda, tetapi melibatkan proses seleksi, validasi ilmiah, serta penyesuaian dengan kebutuhan individu dan konteks budaya pasien (ITSKes ICMe Jombang et al. 2024).

Menurut World Health Organization, integrasi pengobatan tradisional ke dalam sistem kesehatan harus dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keamanan, efektivitas, kualitas, serta aksesibilitas. Dalam konteks kebidanan, integrasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas asuhan ibu dan bayi tanpa mengabaikan nilai-nilai budaya yang dianut masyarakat (Hoenders et al. 2024).

Dengan demikian, integrasi dalam kebidanan dapat diartikan sebagai: "Upaya sistematis dalam menggabungkan praktik tradisional yang aman dan terbukti dengan pelayanan klinis berbasis bukti, guna memberikan asuhan kebidanan yang holistik, berpusat pada perempuan, dan sensitif terhadap budaya" (ITSKes ICMe Jombang et al. 2024; Purba, Sinaga, and Simbolon 2022).

Contoh Kasus Klinis:

Seorang ibu hamil usia 28 tahun, G2P1A0, usia kehamilan 32 minggu, datang ke BPM. Ibu rutin ANC, namun juga mengonsumsi jamu tradisional untuk menjaga stamina kehamilan. Ia bertanya kepada bidan apakah boleh melanjutkan konsumsi jamu tersebut.

Analisis:

- a. Ini contoh nyata kebutuhan integrasi: pasien tidak hanya mengikuti medis, tapi juga tradisional
- b. Bidan tidak boleh langsung melarang tanpa klarifikasi
- c. Langkah tepat:
 - 1) Identifikasi jenis jamu
 - 2) Evaluasi kandungan & keamanan
 - 3) Berikan edukasi berbasis bukti

2. Ruang Lingkup Praktik Tradisional dalam Kebidanan

Praktik tradisional dalam kebidanan mencakup berbagai bentuk intervensi yang telah diwariskan secara turun-temurun dan masih digunakan oleh masyarakat, antara lain:

- a. Perawatan Kehamilan
 - 1) Konsumsi jamu atau herbal tradisional
 - 2) Pijat kehamilan (prenatal massage)



Gambar 5.1 Pijat Kehamilan

- 3) Pantangan makanan berdasarkan budaya
- b. Persalinan
 - 1) Pendampingan oleh dukun bayi



Gambar 5.2 Pendampingan dukun bayi

- 2) Posisi melahirkan tradisional
 - 3) Ritual atau doa tertentu selama persalinan
- c. Masa Nifas
 - 1) Penggunaan bengkung atau stagen



Gambar 5.3 Penggunaan bengkung

- 2) Ramuan herbal (tapel, pilis)
- 3) Pantangan aktivitas dan makanan
- d. Perawatan Bayi Baru Lahir
 - 1) Pijat bayi



Gambar 5.4 Pijat Bayi

- 2) Perawatan tali pusat tradisional
- 3) Bedong dan ritual bayi

Praktik-praktik tersebut memiliki nilai budaya yang kuat, namun memerlukan kajian ilmiah untuk memastikan keamanan dan efektivitasnya.

Kasus Klinis

Ibu nifas hari ke-5 menggunakan bengkung dan mengonsumsi ramuan herbal untuk mempercepat pemulihan. Ia juga membatasi minum karena percaya dapat mempercepat penyembuhan luka.

Analisis

- e. Praktik yang dilakukan:
 - 1) Bengkung → relatif aman jika tidak terlalu ketat
 - 2) Herbal → perlu evaluasi
 - 3) Pembatasan cairan → berbahaya (risiko dehidrasi & gangguan laktasi)
 - f. Tindakan Bidan
 - 1) Edukasi bahwa cairan penting untuk produksi ASI
 - 2) Tidak langsung melarang bengkung, tapi mengatur penggunaannya
 - 3) Evaluasi herbal (komposisi & dosis)
- (Pattinasarany, Nusawakan, and Probowati n.d.; Sri Nuriana et al. 2026)

3. Konsep Praktik Klinis Berbasis Bukti (*Evidence-Based Practice*)

Praktik kebidanan modern didasarkan pada prinsip evidence-based practice (EBP), yaitu penggunaan bukti ilmiah terbaik yang tersedia, dikombinasikan dengan keahlian klinis serta preferensi pasien.

Menurut (ITSKes ICMe Jombang et al. 2024; Panggabean, Riyanto, and Simbolon n.d.) **Tiga komponen utama EBP meliputi:**

a. Bukti ilmiah terkini

Perkembangan praktik kebidanan modern menuntut setiap intervensi, termasuk praktik tradisional, untuk dievaluasi berdasarkan bukti ilmiah terkini. Pendekatan ini bertujuan memastikan bahwa setiap tindakan yang diberikan kepada ibu dan bayi tidak hanya berdasarkan kebiasaan atau budaya, tetapi juga terbukti aman dan efektif secara klinis.

1) Hakikat Bukti Ilmiah dalam Praktik Kebidanan

Bukti ilmiah (scientific evidence) dalam kebidanan umumnya diperoleh dari:

- a) *Randomized Controlled Trial* (RCT)
- b) *Systematic Review dan Meta-analisis*
- c) Pedoman klinis berbasis evidence

Sumber seperti *Cochrane Database of Systematic Reviews* menjadi standar emas karena menyintesis berbagai penelitian dengan metodologi ketat.

2) Bukti Ilmiah pada Praktik Tradisional yang Digunakan dalam Kebidanan

a) Terapi Komplementer untuk Nyeri Persalinan

Penelitian Cochrane menunjukkan bahwa:

- Akupunktur dan hipnosis berpotensi mengurangi nyeri persalinan
- Juga dapat menurunkan kebutuhan analgesik farmakologis
- Namun, jumlah studi masih terbatas dan kualitas bervariasi

Selain itu, terapi seperti:

- Aromaterapi
- Pijat
- Relaksasi

Makna Klinis: Bidan boleh menggunakan terapi ini sebagai pelengkap, bukan pengganti tindakan medis utama.

b) Terapi Komplementer pada Kehamilan dan Nifas

Penelitian terbaru (2024) menunjukkan bahwa terapi komplementer:

- Dapat menurunkan kecemasan dan depresi ibu hamil
- Membantu manajemen nyeri dan kesejahteraan psikologis

Namun:

- Efektivitas sangat tergantung jenis terapi
- Standarisasi masih menjadi masalah utama

Makna Klinis: Integrasi lebih kuat pada aspek:

- Psikologis
- Kenyamanan
- Dukungan emosional

c) Posisi Persalinan (Praktik Tradisional vs Klinis)

Bukti dari systematic review menunjukkan:

- Posisi tegak (tradisional) dapat:
- Memperpendek kala II persalinan
- Mengurangi intervensi (vakum/forceps)

Namun:

Dapat meningkatkan risiko robekan perineum dan perdarahan

Makna Klinis

- Tidak ada satu posisi terbaik
- Pendekatan terbaik: berbasis kenyamanan ibu + pemantauan klinis

d) Terapi Herbal dan Homeopati

Bukti ilmiah menunjukkan:

- Banyak terapi herbal dan homeopati:
- Belum terbukti efektif secara kuat
- Beberapa bahkan setara dengan placebo

Contoh: Homeopati untuk induksi persalinan tidak menunjukkan perbedaan signifikan dibanding placebo

Makna Klinis: Bidan harus sangat hati-hati dalam merekomendasikan herbal.

e) Integrasi Edukasi Komplementer dalam Antenatal Care

Penelitian menunjukkan:

Edukasi yang menggabungkan teknik komplementer (misal: yoga, relaksasi):

- Dapat mengurangi intervensi medis saat persalinan
- Meningkatkan kesiapan ibu menghadapi persalinan

Makna Klinis:

3) Keterbatasan Bukti Ilmiah pada Praktik Tradisional

- a) Beberapa kelemahan utama:
- b) Banyak studi dengan sampel kecil
- c) Desain penelitian kurang kuat
- d) Variasi metode (tidak standar)
- e) Efek placebo tinggi

Sebagian besar praktik tradisional berada pada kategori: "*insufficient evidence*" (bukti belum cukup) bukan berarti tidak bermanfaat, tapi belum terbukti secara ilmiah kuat.

4) Implikasi dalam Praktik Kebidanan

Berdasarkan bukti terkini, integrasi praktik tradisional harus mengikuti klasifikasi berikut:

a) Direkomendasikan (Evidence cukup)

- Teknik relaksasi
- Dukungan psikologis
- Posisi persalinan fleksibel

b) Dapat digunakan dengan pengawasan

- Aromaterapi
- Pijat
- Akupunktur

c) Tidak direkomendasikan / perlu kehati-hatian tinggi

- Herbal tanpa standar
- Homeopati untuk induksi
- Pijat perut pada kehamilan

b. Keahlian klinis tenaga Kesehatan

1) Pengertian Keahlian Klinis dalam Kebidanan

Keahlian klinis merupakan kemampuan profesional bidan dalam melakukan pengambilan keputusan klinis yang tepat berdasarkan:

- a) Pengetahuan ilmiah
- b) Keterampilan praktik
- c) Pengalaman klinis
- d) Pertimbangan situasional pasien

2) Komponen Keahlian Klinis dalam Integrasi

a) Clinical Reasoning (Penalaran Klinis)

Kemampuan berpikir kritis untuk:

- Mengidentifikasi kondisi ibu dan janin
- Menilai apakah praktik tradisional aman atau berisiko
- Menentukan prioritas Tindakan

Contoh:

Ibu hamil ingin pijat perut → Bidan harus langsung berpikir:

- Usia kehamilan?
- Risiko plasenta?
- Ada kontraindikasi?

b) Clinical Decision Making (Pengambilan Keputusan)

Kemampuan menentukan tindakan berdasarkan:

- Evidence
- Kondisi klinis
- Preferensi pasien

Tiga kemungkinan keputusan:

- Diterima aman & bermanfaat
- Dimodifikasi boleh dengan syarat
- Ditolak berisiko

c) Keterampilan Praktis (Clinical Skills)

Meliputi kemampuan teknis seperti:

- Pemeriksaan fisik ibu & janin
- Pemantauan persalinan
- Penanganan kegawatdaruratan

d) Komunikasi Terapeutik

Kemampuan menjelaskan tanpa menghakimi.

Contoh:

Jangan bilang: "Itu salah, tidak boleh!"

Tapi: "Saya paham ini kebiasaan yang baik menurut keluarga, tapi ada risiko untuk ibu dan bayi. Mari kita cari cara yang lebih aman."

e) Kompetensi Budaya (Cultural Competence)

Kemampuan memahami:

- Nilai budaya
- Kepercayaan pasien
- Praktik lokal

Tanpa ini, bidan akan:

- Ditolak pasien
- Kehilangan kepercayaan

3) Peran Keahlian Klinis dalam Proses Integrasi

Keahlian klinis berfungsi sebagai "filter utama" dalam integrasi:

Langkah Integrasi Klinis

- a) Identifikasi praktik tradisional
- b) Analisis risiko & manfaat
- c) Bandingkan dengan evidence
- d) Ambil keputusan klinis
- e) Edukasi pasien
- f) Monitoring hasil

4) Tingkatan Keahlian Klinis (*Clinical Competency Level*)

- a) Novice (Pemula)

- Mengikuti aturan
- Cenderung kaku (semua ditolak atau semua diterima)

b) Competent

- Mulai bisa analisis
- Sudah mempertimbangkan kondisi pasien

c) Proficient

- Memahami konteks budaya
- Fleksibel dalam integrasi

d) Expert

- Intuitif + analitis
- Mampu mengambil keputusan cepat dan tepat
- Menjadi rujukan bagi tenaga lain

Target bidan: minimal proficient

5) Contoh Kasus Klinis Terintegrasi

Kasus

Ibu hamil 34 minggu ingin minum jamu pelancar persalinan.

Analisis Keahlian Klinis

- Clinical reasoning: belum waktunya induksi alami
- Evidence: tidak ada bukti kuat
- Risiko: kontraksi prematur

Keputusan: Ditolak

Pendekatan

- Edukasi risiko
- Berikan alternatif: senam hamil, nutrisi

6) Risiko Jika Keahlian Klinis Tidak Adekuat

Tanpa keahlian klinis:

- Praktik berbahaya bisa "dilegalkan"
- Komplikasi tidak terdeteksi
- Kematian ibu & bayi meningkat

7) Implikasi dalam Pendidikan dan Praktik Kebidanan

Untuk mendukung integrasi, bidan harus:

- Dilatih evidence-based practice
- Diberikan pemahaman praktik tradisional lokal
- Dilatih clinical reasoning berbasis kasus
- Menggunakan pendekatan reflektif dalam praktik

8) Penegasan Konseptual

"Keahlian klinis merupakan fondasi utama dalam integrasi praktik tradisional dan klinis, yang berfungsi sebagai alat seleksi untuk memastikan bahwa

setiap intervensi yang diberikan kepada ibu dan bayi bersifat aman, efektif, dan sesuai dengan prinsip evidence-based practice.”

c. Nilai dan preferensi pasien

Dalam konteks integrasi, praktik tradisional tidak serta-merta ditolak, tetapi dievaluasi melalui pendekatan ilmiah untuk menentukan apakah praktik tersebut:

- 1) Aman
- 2) Efektif
- 3) Dapat diterapkan secara klinis

Kasus Klinis

Seorang ibu inpartu fase aktif memilih menggunakan aromaterapi dan teknik pijat untuk mengurangi nyeri persalinan, dibanding analgesik farmakologis.

Analisis

- 1) Aromaterapi & massage: sudah memiliki evidence moderat
- 2) Tidak mengganggu proses persalinan normal
- 3) Bisa menjadi bagian dari EBP jika:
 - Aman
 - Tidak menggantikan tindakan medis penting

Tindakan Bidan

- 1) Mengizinkan praktik tersebut
- 2) Tetap memantau kemajuan persalinan
- 3) Siap intervensi jika ada komplikasi

Pesan Kunci

EBP bukan hanya “medis modern”, tapi kombinasi bukti dengan preferensi pasien dan klinis.

4. Model Integrasi Praktik Tradisional dan Klinis

Integrasi dapat dilakukan melalui beberapa model pendekatan:

a. Model Paralel

- 1) Praktik tradisional dan klinis berjalan sendiri-sendiri
- 2) Minim komunikasi antar penyedia layanan

b. Model Kolaboratif

- 1) Ada komunikasi antara bidan dan praktisi tradisional
- 2) Praktik tradisional dipertimbangkan dalam asuhan

c. Model Integratif

- 1) Praktik tradisional yang sudah terbukti diintegrasikan dalam pelayanan klinis
- 2) Dilakukan secara sistematis dan terstandar (Levett et al. 2016; Sri Nuriana et al. 2026)

Model integratif merupakan pendekatan yang paling ideal karena mengedepankan keselamatan pasien dan kualitas pelayanan.

Kasus Klinis

Di suatu desa, bidan bekerja sama dengan dukun bayi. Dukun bayi membantu dalam aspek budaya dan pendampingan, sementara persalinan tetap dilakukan oleh bidan.

Analisis: Risiko berkurang karena Tindakan klinis tetap oleh tenaga Kesehatan dan Budaya tetap dihargai

Kelebihan

- a. Meningkatkan kepercayaan masyarakat
- b. Mengurangi persalinan non-medis

Pesan Kunci

Integrasi terbaik terjadi saat tidak ada konflik antara budaya dan keselamatan.

5. Prinsip Dasar Integrasi dalam Kebidanan

Agar integrasi berjalan efektif, diperlukan prinsip-prinsip berikut:

a. Keselamatan (Safety)

Tidak semua praktik tradisional aman. Bidan harus mampu mengidentifikasi risiko.

b. Efektivitas (Effectiveness)

Hanya praktik yang memiliki manfaat klinis yang dapat diintegrasikan.

c. Berbasis Bukti (Evidence-Based)

Menggunakan hasil penelitian ilmiah sebagai dasar pengambilan keputusan.

d. Sensitivitas Budaya (Cultural Sensitivity)

Menghargai nilai dan kepercayaan pasien tanpa mengorbankan keselamatan.

e. Asuhan Berpusat pada Perempuan (Woman-Centered Care)

Mengutamakan kebutuhan, preferensi, dan kenyamanan ibu.

Kasus Klinis

Ibu hamil 36 minggu ingin melakukan pijat perut untuk mempercepat posisi janin masuk panggul.

Analisis berdasarkan prinsip:

- a. Safety: berisiko (dapat menyebabkan solusio plasenta)
- b. Effectiveness: tidak terbukti ilmiah
- c. Evidence-based: tidak direkomendasikan
- d. Cultural sensitivity: tetap dihargai
- e. Woman-centered care: edukasi, bukan memaksa

Tindakan Bidan

- a. Menolak praktik dengan cara edukatif
- b. Menjelaskan risiko secara sederhana

c. Menawarkan alternatif aman (senam hamil, posisi optimal)(Mordeniz 2019)

Pesan Kunci

Integrasi bukan berarti semua diterima, tapi disaring dengan prinsip

6. Peran Bidan dalam Integrasi Praktik

Bidan memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara praktik tradisional dan klinis, dengan peran sebagai:

- a. Edukator: memberikan informasi berbasis bukti kepada pasien
- b. Konselor: membantu ibu mengambil keputusan yang tepat
- c. Advokat: melindungi pasien dari praktik berisiko
- d. Kolaborator: bekerja sama dengan keluarga dan tokoh budaya

Peran ini menuntut bidan untuk tidak hanya kompeten secara klinis, tetapi juga memiliki pemahaman sosial budaya yang kuat.

Kasus Klinis

Seorang ibu percaya bahwa kolostrum adalah "ASI kotor" dan ingin membuangnya, mengikuti anjuran keluarga.

Analisis

- a. Ini masalah budaya + miskonsepsi
- b. Risiko: bayi kehilangan nutrisi awal

Peran Bidan:

- a. Edukator: menjelaskan manfaat kolostrum
- b. Konselor: pendekatan empati
- c. Advokat: melindungi bayi
- d. Kolaborator: melibatkan keluarga(Franklin Larsson et al. 2026)

Pendekatan: Tidak menyalahkan tapi mengganti pemahaman

Pesan Kunci: Peran bidan bukan hanya klinis, tapi juga agen perubahan budaya.

7. Tantangan dalam Integrasi

Beberapa tantangan utama dalam integrasi meliputi:

- a. Kurangnya bukti ilmiah pada praktik tradisional tertentu
- b. Perbedaan paradigma antara tenaga kesehatan dan praktisi tradisional
- c. Kepercayaan masyarakat yang kuat terhadap praktik budaya
- d. Risiko praktik berbahaya yang masih dilakukan

Di sinilah peran akademisi dan peneliti kebidanan menjadi penting untuk menghasilkan bukti ilmiah yang dapat mendukung integrasi.

Kasus Klinis

Seorang ibu lebih memilih melahirkan dengan dukun bayi di rumah karena keluarga tidak percaya fasilitas kesehatan.

Analisis

Tantangan: Kepercayaan budaya, Akses & pengalaman masa lalu

Risiko tinggi: Kegawatdaruratan tidak tertangani

Strategi Bidan

- a. Pendekatan komunitas
- b. Libatkan tokoh masyarakat
- c. Bangun hubungan jangka panjang (Franklin Larsson et al. 2026; Senderovich et al. 2016).

Pesan Kunci: Masalah integrasi bukan hanya klinis, tapi juga sosial dan kepercayaan.

C. Identifikasi Praktik Tradisional Dalam Kebidanan (Analisis Keamanan dan Evidence)

1. Konsep Identifikasi Praktik Tradisional

Identifikasi praktik tradisional merupakan proses sistematis untuk mengenali, mengklasifikasikan, dan mengevaluasi praktik yang digunakan oleh masyarakat dalam kehamilan, persalinan, nifas, dan perawatan bayi baru lahir.

Tujuan utama identifikasi:

- a. Menentukan jenis praktik yang dilakukan masyarakat
- b. Menilai keamanan dan risiko
- c. Mengkaji kesesuaian dengan evidence-based practice
- d. Menjadi dasar pengambilan keputusan klinis bidan

Identifikasi ini penting karena tidak semua praktik tradisional bersifat berbahaya sebagian justru memiliki manfaat jika digunakan secara tepat (Dian Purnama Putri et al. 2025; Mordeniz 2019).

2. Klasifikasi Praktik Tradisional dalam Kebidanan

(Ningrum, Purnamasari, and Rohmah 2024; Withers, Kharazmi, and Lim 2018) menyampaikan Praktik tradisional dapat diklasifikasikan menjadi 4 kelompok utama:

- a. Praktik Herbal (Jamu dan Tanaman Obat)

Contoh:

- 1) Jamu kunyit asam



Gambar 5.5 Jamu Kunyit Asam

- 2) Daun katuk untuk ASI
- 3) Jamu pelancar persalinan

Tabel 5.1 analisis keamanan

Praktik	Status	Alasan
Daun katuk	Aman (terbatas)	Mendukung produksi ASI
Jahe (dosis kecil)	Aman	Mengurangi mual
Jamu tidak terstandar	Hati-hati	Komposisi tidak jelas
Jamu pelancar persalinan	Tidak aman	Risiko kontraksi prematur

Herbal boleh digunakan jika:

- 1) Dosis jelas
 - 2) Tidak mengandung bahan berbahaya
 - 3) Tidak mengganggu kehamilan
- b. Praktik Manipulatif (Pijat dan Sentuhan)

Contoh:

- 1) Pijat kehamilan
- 2) Pijat bayi



Gambar 5.6 Pijat Bayi

- 3) Urut perut untuk posisi janin

Tabel 5.2 analisis keamanan

Praktik	Status	Alasan
Pijat relaksasi	Aman	Mengurangi stres
Pijat bayi	Aman	Mendukung tumbuh kembang
Urut perut	Tidak aman	Risiko solusio plasenta

Catatan Klinis: Area abdomen pada kehamilan = zona risiko tinggi

c. Praktik Budaya dan Ritual

Contoh:

1) Mitoni (7 bulanan)



Gambar 5.7 Mitoni

2) Pantangan makanan

3) Ritual doa

Tabel 5.3 analisis keamanan

Praktik	Status	Alasan
Ritual/doa	Aman	Dukungan psikologis
Pantangan ringan	Hati-hati	Bisa berdampak nutrisi
Pantangan ekstrem	Tidak aman	Risiko malnutrisi

Catatan Klinis: Budaya tidak selalu salah, tapi harus disaring dampaknya

d. Praktik Perawatan Nifas dan Bayi

Contoh:

1) Bengkung/stagen

2) Tapel/pilis

3) Bedong bayi (Aktaş Reyhan, Dağlı, and Yeşildere Sağlam 2025; Kassie et al. 2022)



Gambar 5.8 Bedong bayi

4) Perawatan tali pusat dengan bahan tradisional

Tabel 5.4 analisis keamanan

Praktik	Status	Alasan
Bengkung (tidak ketat)	Aman	Dukungan otot
Bedong longgar	Aman	Memberi kenyamanan
Tapel/pilis	Hati-hati	Risiko iritasi
Bahan pada tali pusat	Tidak aman	Resiko infeksi

3. Kriteria Penilaian Keamanan Praktik Tradisional

Bidan harus menggunakan kriteria berikut:

- a. Evidence (Bukti ilmiah)
 - 1) Ada penelitian atau tidak
 - 2) Direkomendasikan atau tidak
- b. Safety (Keamanan)
 - 1) Risiko langsung
 - 2) Risiko jangka panjang
- c. Dosis dan Standarisasi
 - 1) Jelas atau tidak
 - 2) Konsisten atau tidak
- d. Kondisi Pasien: Normal vs risiko tinggi(Hertati, Natalia, and Stefanicia 2024; Ningrum et al. 2024)

4. Kategori Praktik Berdasarkan Evidence

Kategori A (Direkomendasikan)

- a. Pijat relaksasi
- b. Dukungan psikologis
- c. Posisi persalinan fleksibel

Kategori B (Boleh dengan pengawasan)

- a. Aromaterapi
- b. Herbal ringan
- c. Bengkung

Kategori C (Tidak direkomendasikan)

- a. Urut perut
- b. Herbal tidak jelas
- c. Perawatan tali pusat tradisional(Liira et al. 2014; Pattinasarany et al. n.d.)

5. Contoh Kasus Klinis Identifikasi

Kasus: Ibu nifas hari ke-3 menggunakan: Bengkung ketat minum jamu tidak mau minum banyak air.

Identifikasi

Praktik	Status	Tindakan Bidan
Bengkung ketat	Hati-hati	Dukungan otot
Jamu	Hati-hati	Memberi kenyamanan
Kurang Minum	Tidak aman	Risiko iritasi

6. Tantangan dalam Identifikasi

- a. Variasi praktik antar daerah
- b. Informasi tidak terdokumentasi

- c. Kepercayaan masyarakat tinggi
- d. Kurangnya penelitian lokal

Solusi:

- a. Pendekatan budaya
- b. Edukasi berbasis bukti
- c. Penelitian kebidanan lokal (Aktaş Reyhan, Dağlı, and Yeşildere Sağlam 2025; Kassie et al. 2022; Levett et al. 2016)

7. Penegasan Konseptual

Identifikasi praktik tradisional merupakan langkah awal dalam integrasi kebidanan, yang bertujuan untuk memilah praktik yang aman dan bermanfaat dari praktik yang berisiko, sehingga dapat mendukung pelayanan kebidanan yang berkualitas dan berbasis bukti.

D. Penutup

Identifikasi praktik tradisional dalam kebidanan merupakan langkah fundamental dalam upaya integrasi antara pendekatan budaya dan pelayanan klinis modern. Melalui proses identifikasi yang sistematis, bidan dapat mengenali berbagai praktik yang berkembang di masyarakat, memahami makna budaya yang melatarbelakanginya, serta menilai tingkat keamanan dan manfaatnya secara ilmiah.

Hasil identifikasi menunjukkan bahwa praktik tradisional tidak bersifat homogen. Sebagian praktik terbukti aman dan bahkan memberikan manfaat, terutama dalam aspek kenyamanan, dukungan psikologis, dan peningkatan kesejahteraan ibu. Namun, terdapat pula praktik yang berpotensi menimbulkan risiko, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kesehatan ibu dan bayi, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan herbal tanpa standar, manipulasi fisik pada kehamilan, serta perawatan bayi yang tidak sesuai prinsip sterilitas.

Oleh karena itu, peran bidan menjadi sangat strategis sebagai filter klinis dalam menentukan praktik yang dapat diintegrasikan, dimodifikasi, atau harus dieliminasi. Keputusan tersebut harus didasarkan pada prinsip evidence-based practice, keselamatan pasien, serta sensitivitas terhadap nilai budaya. Pendekatan ini memungkinkan terciptanya asuhan kebidanan yang tidak hanya aman dan efektif, tetapi juga menghargai kepercayaan dan kearifan lokal masyarakat.

Lebih lanjut, identifikasi praktik tradisional juga membuka peluang bagi pengembangan penelitian kebidanan, khususnya dalam mengkaji praktik-praktik lokal yang belum memiliki bukti ilmiah yang kuat. Dengan demikian, integrasi praktik tradisional dan klinis tidak hanya menjadi bentuk adaptasi pelayanan

kesehatan, tetapi juga kontribusi nyata dalam pengembangan ilmu kebidanan berbasis konteks budaya.

Sebagai penegasan, identifikasi praktik tradisional bukanlah upaya untuk menilai benar atau salahnya suatu budaya, melainkan proses ilmiah untuk memastikan bahwa setiap praktik yang diterapkan dalam asuhan kebidanan memberikan manfaat optimal tanpa mengabaikan aspek keselamatan ibu dan bayi. Dengan pendekatan ini, bidan diharapkan mampu menjadi agen integrasi yang profesional, kritis, dan humanistik dalam memberikan pelayanan kebidanan yang berkualitas

Referensi

- Aktaş Reyhan, Feyza, Elif Dağlı, and Havva Yeşildere Sağlam. 2025. "The Place of Evidence - Based Practices in Theoretical and Clinical Practice From the Perspective of Midwifery Students: A Qualitative Study." *Journal of Evaluation in Clinical Practice* 31(2):e70067. doi:10.1111/jep.70067.
- Dian Purnama Putri, Sefentina Agustin, Aliya Aliya, and Aviliyani Aviliyani. 2025. "Integrasi Asuhan Kebidanan Modern Dan Tradisional Pada Adat Dayak." *JURNAL RISET RUMPUN ILMU KEDOKTERAN* 4(2):51–58. doi:10.55606/jurrike.v4i2.6099.
- Franklin Larsson, Lise-Lotte, Solomon Hailemeskel, Helena Lindgren, Ulrika Byrskog, Michael B. Wells, Johanna Blomgren, Joyce Jebet Cheptum, Kaddy Ceesay, and Kerstin Erlandsson. 2026. "Transitioning to Midwifery Models of Care: Implementation Insights from Focus Groups with Health Leaders in Two African Countries." *African Journal of Primary Health Care & Family Medicine* 18(1):a5238. doi:10.4102/PHCFM.v18i1.5238.
- Hertati, Dessy, Vita Natalia, and Stefanicia Stefanicia. 2024. "Pengaruh Praktik Budaya dan Kesehatan pada Ibu Masa Nifas di daerah Aliran Sungai (DAS) Tahun 2023: The Effect of culture and Health Practices on Postpartum Mother in the River Watershed Area (DAS) in 2023." *Jurnal Surya Medika* 9(3):190–202. doi:10.33084/jsm.v9i3.6488.
- Hoenders, Rogier, Ricardo Ghelman, Caio Portella, Samantha Simmons, Amy Locke, Holger Cramer, Daniel Gallego-Perez, and Miek Jong. 2024. "A Review of the WHO Strategy on Traditional, Complementary, and Integrative Medicine from the Perspective of Academic Consortia for Integrative Medicine and Health." *Frontiers in Medicine* 11:1395698. doi:10.3389/fmed.2024.1395698.
- ITSKes ICMe Jombang, Rista Novitasari, Hidayatun Nufus,ITSKes ICMe Jombang, Evi Rosita, andITSKes ICMe Jombang. 2024. "ANALISIS PENERAPAN INTEGRASI

- KEBIDANAN KONVENSIONAL DAN KOMPLEMENTER DALAM PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK PADA RUMAH SAKIT ASFIYAK KEDIRI." *Journal of Nursing and Health* 9(4):523–31. doi:10.52488/jnh.v9i4.442.
- Kassie, Aychew, Alemnew Wale, Desalegn Girma, Hailemariam Amsalu, and Mastewal Yechale. 2022. "The Role of Traditional Birth Attendants and Problem of Integration with Health Facilities in Remote Rural Community of West Omo Zone 2021: Exploratory Qualitative Study." *BMC Pregnancy and Childbirth* 22(1):425. doi:10.1186/s12884-022-04753-5.
- Levett, Kate M., C. A. Smith, A. Bensoussan, and H. G. Dahlen. 2016. "Complementary Therapies for Labour and Birth Study: A Randomised Controlled Trial of Antenatal Integrative Medicine for Pain Management in Labour." *BMJ Open* 6(7):e010691. doi:10.1136/bmjopen-2015-010691.
- Liira, Juha, Jos H. Verbeek, Giovanni Costa, Tim R. Driscoll, Mikael Sallinen, Leena K. Isotalo, and Jani H. Ruotsalainen. 2014. "Pharmacological Interventions for Sleepiness and Sleep Disturbances Caused by Shift Work" edited by Cochrane Work Group. *Cochrane Database of Systematic Reviews* 2014(8). doi:10.1002/14651858.CD009776.pub2.
- Mordeniz, Cengiz. 2019. "Integration of Traditional and Complementary Medicine into Evidence-Based Clinical Practice." in *Traditional and Complementary Medicine*, edited by C. Mordeniz. IntechOpen.
- Ningrum, Widya Maya, Kurniati Devi Purnamasari, and Siti Rohmah. 2024. "Kearifan Lokal Kagaluhan: Menggali Praktik Tradisional Kesehatan Ibu Melahirkan di Kampung Naga." *Journal of Midwifery and Public Health* 4(2):68. doi:10.25157/jmph.v4i2.16293.
- Panggabean, Hetty, Ontran Sumantri Riyanto, and Juana Linda Simbolon. n.d. "Tinjauan Hukum Pengobatan Tradisional Komplementer Tenaga Kesehatan Di Fasilitas Pelayanan Kebidanan."
- Pattinasarany, Gracia Marceilina, Arwyn Weynand Nusawakan, and Hapsari Probowati. n.d. "Praktik Tradisional Pada Perawatan Masa Nifas."
- Purba, Yeni Trisna, Arthaully Gracia Sinaga, and Putri Handayani Simbolon. 2022. "INTEGRASI PELAYANAN KEBIDANAN BERBASIS KOMUNITAS DALAM SISTEM KESEHATAN PRIMER." *Jurnal Minfo Polgan* 11(1):172–77. doi:10.33395/jmp.v11i1.15395.
- Senderovich, Helen, Mary Lou Ip, Anna Berall, Jurgis Karuza, Michael Gordon, Malcolm Binns, Shaira Wignarajah, Daphna Grossman, and Lynda Dunal. 2016. "Therapeutic Touch® in a Geriatric Palliative Care Unit – A Retrospective Review."

Complementary Therapies in Clinical Practice 24:134–38.
doi:10.1016/j.ctcp.2016.06.002.

Sri Nuriana, Achmad Hilal, Nahdah, Hartati, and Riska Sabriana. 2026. "Hubungan Budaya Lokal Dengan Praktik Perawatan Kehamilan Dan Persalinan Pada Masyarakat Tradisional." *Journal of Innovative and Creativity (Joecy)* 6(1):3011–19. doi:10.31004/joecy.v6i1.7233.

Withers, Mellissa, Nina Kharazmi, and Esther Lim. 2018. "Traditional Beliefs and Practices in Pregnancy, Childbirth and Postpartum: A Review of the Evidence from Asian Countries." *Midwifery* 56:158–70. doi:10.1016/j.midw.2017.10.019.

PROFIL PENULIS



Dian Rahmawati, SST., MPH. Lahir di Kediri, 31 Oktober 1984. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D4 Bidan Pendidik pada Program Studi D4 Bidan Pendidik, Poltekkes Kemenkes Malang tahun 2009. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Sebelas Maret Surakarta dan lulus tahun pada tahun 2016. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2009 di Akademi Kebidanan Dharma Husada Kediri. Saat ini penulis bekerja di Universitas STRADA Indonesia mengampu mata kuliah Asuhan Kegawatdaruratan Maternal, Asuhan Kehamilan, dan Asuhan Neonatus, Bayi, dan Balita. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan

Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar nasional dan internasional. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: dianrahmawati3110@gmail.com



Dr. Nurdiana Lante, S.ST., M.Kes. Lahir di Ujung Pandang (Sulawesi Selatan) 17 Mei 1978, Menyelesaikan Pendidikan Sekolah Perawat Kesehatan/SPK Depkes Ternate (1995), Program Pendidikan Bidan (1996) Pendidikan Diploma III Kebidanan Poltekkes Ternate (2005), Pendidikan Diploma IV Bidan Pendidik Poltekkes Ternate (2010), Pendidikan Magister Kesehatan Universitas Hasanuddin Makassar (2016), dan Lulus Program Doktorat (S3) di Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2025. Memulai karir sebagai Bidan PTT di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara (1997-2004), PNS Dinas Kesehatan

Kota Ternate (2005-2016) Tahun 2017 sampai saat ini sebagai Dosen pada program studi Diploma IV Kebidanan Poltekkes Kemenkes Ternate.

Penulis dapat dihubungi melalui email: nurdianalante@gmail.com



Sahnawi Marsaoly, S.Kep., M.Kes. Dosen Program Studi Diploma III Kebidanan Poltekkes Kemenkes Ternate Lahir di Sanana, 02 Juli 1964. Menyelesaikan Pendidikan Diploma Tiga Keperawatan thn 1987 di Makassar, Kemudian mengajar pada SPK Depkes Ternate hingga tahun 1995 mengikuti Pendidikan Bidan B, selesai pendidikan Bidan, penulis mengajar pada Akademi Kebidanan Depkes Ternate. Pada Tahun 2001, ketika pembentukan Poltekkes Kemenkes Ternate, penulis menjadi dosen tetap di jurusan Kebidanan. Selesai Pendidikan Magister Kesehatan, selain mengajar, penulis pernah menjabat sebagai ketua Unit Jaminan Mutu Poltekkes Ternate, Ketua Jurusan Kesehatan Lingkungan, Ketua Jurusan Kebidanan, dan Wakil Direktur III, bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama. Saat ini kembali ke home base sebagai dosen jurusan Kebidanan. Penulis bias dihubungi pada email sahnawin64@gmail.com

Motto: ***“Jadilah manusia terbaik disisi Allah, jadilah manusia biasa dihadapan orang lain dan jadilah manusia terburuk dalam pandangan diri sendiri”, (Ali Bin Abi Thalib).***



Dr. Bd. Silvia Nova, SST., M.Kes. penulis, lahir di Duri pada tanggal 21 Maret 1985. Penulis adalah dosen DIII Prodi Kebidanan Institut Kesehatan Helvetia Pekanbaru. Penulis menjalani pendidikan DIII Kebidanan di Akademi Kebidanan Deli Husada Deli Tua, Medan. Untuk Pendidikan D-IV Kebidanan, Profesi Bidan, dan S2 Kesehatan Masyarakat, penulis menjalani di STIKes Helvetia Medan. Penulis menyelesaikan pendidikan S3 Kesmas di Universitas Airlangga.

Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: silvianova@helvetia.ac.id

Buku yang pernah ditulis antara lain: Farmakologi Dasar, Latihan Soal Uji Kompetensi DIII dan Profesi Bidan Edisi I, Kesehatan Perempuan dan Keluarga Berencana, Kesehatan Mental pada Ibu Hamil dan Ibu Pasca Melahirkan, Bunga Rampai Peran Tenaga Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan. Penulis memiliki ketertarikan di bidang kebidanan dan kesehatan masyarakat dan aktif sebagai peneliti dan penulis artikel jurnal ilmiah di bidang kesehatan. Penulis juga tergabung sebagai anggota IBI dan AIPKIND Kota Pekanbaru. Penulis berkeinginan mengembangkan ilmu kebidanan melalui beberapa buku yang ditulis. Semoga bermanfaat bagi pembaca, baik mahasiswa maupun dosen kebidanan, serta masyarakat umum.



Siti Komariyah, S.SiT., M.Kes. Penulis lahir di Tulungagung, domisili di Kota Kediri. Penulis menyelesaikan pendidikan SPK di SPK Pemkab Kabupaten Tulungagung, Pendidikan P2B di RS Baptis Kota Kediri, Diploma 3 Kebidanan Akademi Kebidanan Dharma Husada Kediri, D4 Bidan Pendidik di FK UGM Yogyakarta, S2 Pendidikan Kesehatan di UNS lulus tahun 2009, saat ini sedang menempuh program Doktoral.

Riwayat karir, Penulis pernah bekerja di RSIA Trisna Medika Tulungagung Akademi Kesehatan Dharma Husada Kediri prodi D III Kebidanan mulai tahun 2003 sampai dengan April 2024. Universitas Strada Indonesia (USI) Prodi Profesi Kebidanan DARI 2024 sampai sekarang. Buku yang pernah

di tulis diantaranya tentang Kesehatan Reproduksi , Stimulasi Anak tumbuh kembang anak , Peduli Kesehatan Reproduksi Wanita, Diagnostik asuhan kebidanan pada kehamilan dengan permasalahannya, Buku Ajar Psikologi Kebidanan, Kumpulan Latihan Soal Osce Kebidanan, SOP Pelayanan Kebidanan masa persalinan, buku ajar persalinan, masih Saat ini penulis juga aktif dalam kegiatan penelitian kesehatan khususnya kebidanan yang telah terbit di jurnal Sinta, aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat dan terpublikasi di Jurnal Nasional. Jalin kerja sama dengan penulis via surel sitikomariyah.dh@gmail.com.

Sinopsis

"Buku referensi Kebidanan Transkultural dalam Masyarakat Multikultural Indonesia membahas secara komprehensif pentingnya pendekatan budaya dalam pelayanan kebidanan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Sebagai negara multikultural, Indonesia memiliki berbagai nilai, kepercayaan, adat istiadat, dan praktik sosial yang dapat memengaruhi cara perempuan, keluarga, dan masyarakat memahami kesehatan, kehamilan, persalinan, nifas, menyusui, serta perawatan bayi baru lahir.

Buku ini menguraikan konsep dasar kebidanan transkultural, karakteristik masyarakat multikultural, pengaruh budaya terhadap perilaku kesehatan ibu dan anak, serta peran bidan dalam memberikan pelayanan yang sensitif budaya. Pembahasan juga mencakup komunikasi lintas budaya, etika dalam pelayanan kebidanan, pengambilan keputusan berbasis nilai budaya, serta strategi edukasi kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Melalui penyajian yang sistematis dan aplikatif, buku ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan bagi mahasiswa kebidanan, dosen, bidan praktisi, tenaga kesehatan, peneliti, dan pemerhati kesehatan ibu dan anak. Kehadiran buku ini tidak hanya memberikan pemahaman teoritis, tetapi juga memperkuat kemampuan bidan dalam memberikan pelayanan yang aman, humanis, profesional, inklusif, dan menghargai keberagaman budaya masyarakat Indonesia.

Dengan membaca buku ini, pembaca diharapkan mampu memahami bahwa keberhasilan pelayanan kebidanan tidak hanya ditentukan oleh ketepatan tindakan klinis, tetapi juga oleh kemampuan bidan dalam membangun hubungan empatik, menghormati nilai budaya pasien, serta menyesuaikan pendekatan pelayanan dengan kondisi sosial budaya setempat. Buku ini menjadi referensi penting dalam mendukung terciptanya pelayanan kebidanan yang bermartabat, berkeadilan, dan berpusat pada perempuan, keluarga, serta komunitas."

"Buku referensi Kebidanan Transkultural dalam Masyarakat Multikultural Indonesia membahas secara komprehensif pentingnya pendekatan budaya dalam pelayanan kebidanan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Sebagai negara multikultural, Indonesia memiliki berbagai nilai, kepercayaan, adat istiadat, dan praktik sosial yang dapat memengaruhi cara perempuan, keluarga, dan masyarakat memahami kesehatan, kehamilan, persalinan, nifas, menyusui, serta perawatan bayi baru lahir.

Buku ini menguraikan konsep dasar kebidanan transkultural, karakteristik masyarakat multikultural, pengaruh budaya terhadap perilaku kesehatan ibu dan anak, serta peran bidan dalam memberikan pelayanan yang sensitif budaya. Pembahasan juga mencakup komunikasi lintas budaya, etika dalam pelayanan kebidanan, pengambilan keputusan berbasis nilai budaya, serta strategi edukasi kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Melalui penyajian yang sistematis dan aplikatif, buku ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan bagi mahasiswa kebidanan, dosen, bidan praktisi, tenaga kesehatan, peneliti, dan pemerhati kesehatan ibu dan anak. Kehadiran buku ini tidak hanya memberikan pemahaman teoritis, tetapi juga memperkuat kemampuan bidan dalam memberikan pelayanan yang aman, humanis, profesional, inklusif, dan menghargai keberagaman budaya masyarakat Indonesia.

Dengan membaca buku ini, pembaca diharapkan mampu memahami bahwa keberhasilan pelayanan kebidanan tidak hanya ditentukan oleh ketepatan tindakan klinis, tetapi juga oleh kemampuan bidan dalam membangun hubungan empatik, menghormati nilai budaya pasien, serta menyesuaikan pendekatan pelayanan dengan kondisi sosial budaya setempat. Buku ini menjadi referensi penting dalam mendukung terciptanya pelayanan kebidanan yang bermartabat, berkeadilan, dan berpusat pada perempuan, keluarga, serta komunitas."

Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620



ISBN 978-634-7556-99-8 (PDF)



9

786347

556998